

Autores: D. P. Boer, S. Hart, P.R. Kropp y Ch. D. Webster

Adaptación: Ed Hilterman y A. Andrés-Pueyo

UB-Grupo de Estudios Avanzados en Violencia

(VERSIÓN ESPAÑOLA-MAYO 2005)

SVR-20

Manual de valoración del riesgo de violencia sexual

Publicacions i Edicions



UNIVERSITAT DE BARCELONA



Autores: D. P. Boer, S. Hart, P.R. Kropp y Ch. D. Webster

Adaptación: Ed Hilterman y A. Andrés-Pueyo
UB-Grupo de Estudios Avanzados en Violencia
(VERSIÓN ESPAÑOLA-MAYO 2005)

SVR-20

Manual de valoración del riesgo de violencia sexual

Publicacions i Edicions



UNIVERSITAT DE BARCELONA



Índice

Prefacio a la edición en español	v
Prólogo	vii
Introducción	1
Aspectos genéricos de la valoración	11
Definición de la violencia sexual	11
La realización de valoraciones del riesgo de violencia sexual	12
Factores de riesgo	16
Directrices para la toma de decisiones	22
La comunicación de los resultados	23
El SVR-20	31
Limitaciones	34
Procedimiento de evaluación	36
Re-valoraciones	43
Documentación de los resultados	44
Definición de los factores de riesgo	49
1. Desviación sexual	50
2. Víctima de abuso en la infancia	53
3. Psicopatía	55
4. Trastorno mental grave	57
5. Problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas	59
6. Ideación suicida/homicida	61
7. Problemas en las relaciones sentimentales de pareja ...	63
8. Problemas de empleo	65
9. Antecedentes de delitos violentos no sexuales	67
10. Antecedentes de delitos no violentos	69
11. Fracaso en las medidas de supervisión previas	71
12. Frecuencia elevada de delitos/agresiones sexuales	74
13. Tipos múltiples de delitos sexuales	76

14. Daño físico a la(s) víctima(s) de los delitos sexuales	78
15. Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexuales	80
16. Progresión en la frecuencia y/o gravedad de los delitos sexuales	82
17. Minimización extrema o negación de los delitos sexuales	84
18. Actitudes que apoyan o consienten los delitos sexuales	86
19. Carencia de planes de futuro realistas	89
20. Actitud negativa hacia la intervención	91
Otras consideraciones	93
Bibliografía	97
SVR-20	109

Prefacio a la edición en español

El abuso sexual y las agresiones sexuales constituyen problemas de comportamiento y fenómenos criminales de alta prevalencia en todas las sociedades, estimándose que hasta un 20% de los varones y hasta un 30% de las mujeres han sufrido algún episodio de victimación sexual a lo largo de su vida. Ello significa que son muchos también los varones que han llevado a cabo algún tipo de abuso o agresión sexual en algún momento.

Con todo, es evidente que las situaciones más graves y dañinas para las víctimas son aquellas que comportan el abuso prolongado sobre menores y los episodios de agresión sexual y violación, en los que se ejerce gran violencia sobre las víctimas. De muchos de estos comportamientos son responsables algunos agresores sistemáticos, que han cometido muchos delitos sexuales en el pasado y que probablemente cometerán otros en el futuro. Es frecuente que tales agresores, antes o después, acaben ante los tribunales de justicia y, a la postre, condenados a penas de prisión. En España alrededor del 5% de la población penitenciaria corresponde a sujetos encarcelados por delitos sexuales, lo que en la actualidad (2005) supone en torno a tres mil presos. Las tasas globales de reincidencia sexual de esta tipología de agresores son de entre el 18% y el 20%, para períodos de seguimiento de alrededor de cuatro años (Luque, Ferrer y Capdevila, 2005; Redondo, Navarro, Martínez, Luque y Andrés, 2005). Es cierto que en dichas tasas globales están representados tanto un amplio sector de sujetos que probablemente no reincidirán como un pequeño grupo de ellos con una alta probabilidad de cometer múltiples agresiones posteriores.

Un reto notable del presente, que demandan tanto la sociedad como los poderes públicos, es poder anticipar, del modo más veraz y justo posible, el riesgo que tienen los agresores sexuales de repetición de su comportamiento. Y tales estimaciones de riesgo parecen oportunas y necesarias tanto para la propia individualización de las penas y medidas que la justicia puede aplicar como para orientar convenientemente las intervenciones preventivas o de tratamiento con dichos sujetos.

Hace algunos años un equipo de investigadores de la Universidad Simon Fraser de Vancouver (Canadá) integrado por Boer, Hart, Kropp y Webster (1997), desarrollaron, a partir de la investigación acumulada sobre agresores sexuales, el *Sexual Violence Risk* (SVR-20). Se trata de un instrumento de valoración de 20 ítems o campos de información sobre un determinado caso, que permiten una ponderación de su riesgo de violencia sexual en las categorías bajo, moderado o alto. Este instrumento ha sido traducido y adaptado al idioma español y al contexto latino por el Prof. Antonio Andrés Pueyo junto con Magali Martínez y Ed Hilberman, en el marco del *Grupo de Estudios Avanzados en Violencia-GEAV*, en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Barcelona y financiado, en parte, por el proyecto SEC2001-3821-C05-01 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En este breve prefacio para la primera edición en español, no puedo sino felicitar a los autores que desarrollaron el SVR-20 original y a los autores de la versión española, por su concienzudo esfuerzo técnico en pro de una mejora de los sistemas evaluativos del riesgo en un campo tan importante y difícil como el de la agresión sexual. A partir de ahora también los expertos españoles y latinoamericanos, tales como psicólogos, psiquiatras, criminólogos y otros especialistas forenses disponen de un instrumento probado internacionalmente que puede ayudarles a realizar, con mayor precisión, sus diagnósticos y valoraciones de riesgo de violencia sexual. También es importante que todo el trabajo aplicado en torno a la predicción de riesgo de violencia sexual que ahora puede comenzar, sistemáticamente realizado y evaluado, contribuya a la investigación y mejora de este y otros instrumentos predictivos.

SANTIAGO REDONDO ILLESCAS

Prólogo

(de la edición original del SVR-20)

Este manual describe uno de los instrumentos de valoración del riesgo de violencia desarrollados en los últimos años por académicos y profesionales de la salud mental y forenses pertenecientes al Mental Health, Law, and Policy Institute de la Simón Fraser University (Vancouver, Canadá). Uno de nosotros (CDW) lleva muchos años implicado en la investigación sobre violencia y a pesar de que el resto tiene experiencia en este campo de la investigación y por tanto acumulamos experiencia en los procedimientos de valoración clínicos, nuestro reciente trabajo en la valoración de riesgo es algo diferente: Por primera vez nos dirigimos a profesionales que realizan su trabajo en contextos aplicados y no en el marco de la investigación.

El trabajo que presentamos es el resultado de tres colaboraciones distintas. La primera es la del Dr. Derek Eaves de los Servicios Psiquiátricos de la Columbia Británica y del Dr. Kevin Douglas de Simón Fraser University. Esta asociación ha patrocinado la edición de los manuales destinados a la valoración del de violencia contra la pareja y otro para valorar el riesgo de violencia en poblaciones de enfermos mentales(1). Aquel que esté familiarizado con estos instrumentos de valoración reconocerá su influencia en la “forma y aspecto” de este manual.

La segunda colaboración es de los doctores Randy Atkinson y Richard Laws de los Servicios de Psiquiátrica Forense de la Columbia Británica. Sus trabajos dieron como resultado un protocolo para la evaluación del riesgo de violencia sexual para su utilización en su provincia (2). Nuestro objetivo al escribir este manual es extender y clarificar aquel protocolo inicial, que era muy detallado y que probablemente eran idóneos para profesionales de la salud mental y extenderlo a otros profesionales y para una audiencia más general.

La tercera colaboración es de los doctores Robin Wilson y Claudine Gauthier de los Servicios Penitenciarios de Canadá y del Dr. Brian Judd, psicólogo forense, en ejercicio profesional

privado en Seattle, Washington. Nuestras discusiones con estos colegas nos clarificaron muchos problemas y nos ayudaron a recordar la realidad clínica de las valoraciones del riesgo. También nos ayudaron con el trabajo de los primeros borradores y protocolos iniciales que dieron lugar al material aquí presentado (Boer, Wilson, Gauthier, & Hart, 1997; Hart, Judd, & Boer, 1996).

Los lectores deben tener presente que el SVR-20 es un trabajo en marcha. El manual se actualizará para reflejar los desarrollos que aparecen en las publicaciones científicas y profesionales. Como autores estaremos encantados de recibir cualquier comentario que ayude a mejorar las ediciones futuras.

Finalmente, queremos mencionar que el orden en que están escritos los autores en esta guía corresponde a la denominación alfabética de sus apellidos y no corresponde a ningún orden acerca de las contribuciones relativas de los autores.

(1) *The Spousal Assault Risk Assessment Guide* (SARA; Kropp, Hart, Webster, & Eaves, 1994, 1995) and the *HCR-20* (Webster, Eaves, Douglas, & Wintrup, 1995; Webster, Douglas, Eaves, & Hart, 1997).

(2) *The Sex Offender Risk Assessment Guide* (Atkinson, Kropp, Laws, & Hart, 1995).

Introducción

El concepto de riesgo es complejo y está estrechamente relacionado con las nociones de peligrosidad y de probabilidad (Bernstein, 1996). El término riesgo hace referencia a un 'peligro' que se comprende parcialmente, de modo que su ocurrencia sólo se puede predecir con incertidumbre y en términos probabilísticos. El riesgo es un concepto multifacético y se refiere a: (1) la naturaleza del peligro, (2) la probabilidad de ocurrencia de dicho peligro, (3) la frecuencia con la que ese peligro es probable que suceda, (4) la gravedad de sus consecuencias, y (5) la inminencia del peligro (ver Janus y Meehl, 1997). Los esfuerzos por comprender y evitar el riesgo —un proceso que se identifica a veces con la valoración del riesgo— se han convertido en un objetivo fundamental en muchos campos, incluyendo el derecho, los negocios, la medicina y la ingeniería (Bernstein, 1996; Menzies, Webster y Hart, 1995). Podemos decir que la valoración del riesgo es el proceso de identificación y estudio de los 'peligros' con el objetivo último de reducir la probabilidad de su ocurrencia.

Los científicos sociales y los profesionales de la salud mental que se interesan por la violencia tienden a definir la valoración del riesgo como un proceso de evaluación con el fin de (1) caracterizar el riesgo de realizar actos violentos en el futuro, y (2) elaborar intervenciones para controlar o reducir dicho riesgo (ver Monahan, 1981/1995; Monahan y Steadman, 1994). La toma de decisiones en la valoración del riesgo se ha orientado según dos tradiciones (ver Menzies et al., 1995; Monahan, 1981/1995). Históricamente, la más utilizada ha sido el juicio clínico (también llamado profesional) no estructurado. El elemento más distintivo y relevante de este enfoque es que no pone límites ni restricciones al modo cómo los evaluadores realizan juicios valorativos a partir de la información de que disponen (Meehl, 1954/1996). También es frecuente que los evaluadores tengan una absoluta discrecionalidad sobre la recogida de la información y cómo ésta se utiliza en la elaboración del juicio o decisión final. No es sorprendente que se describa

el juicio clínico no estructurado como algo “informal, subjetivo e intuitivo” (Grove y Meehl, 1996; p. 293). El segundo enfoque es la valoración actuarial del riesgo. Lo más destacado de este segundo enfoque es que, en base a la información disponible, los evaluadores realizan un juicio y toman una decisión última siguiendo unas reglas fijas y explícitas (Meehl, 1954/1996). Generalmente las decisiones actuariales se fundamentan en datos específicos de la valoración, seleccionados porque su relación con la violencia ha sido demostrada empíricamente. El enfoque actuarial también recibe el nombre de “mecánico” y “algorítmico” (Grove y Meehl, 1996; p. 293).

El enfoque del juicio clínico no estructurado en la valoración del riesgo ha sido criticado por varias razones (Monahan, 1981/1995; ver también Litwack y Schlesinger, 1987; Monahan y Steadman, 1994; Webster, Harris, Rice, Cormier y Quinsey, 1994). Primero, comporta una tendencia a la falta de consistencia o acuerdo entre evaluadores acerca de cómo se han de realizar las evaluaciones y cómo se toman las decisiones (baja fiabilidad entre observadores). Segundo, hay poca evidencia sobre la precisión de las decisiones tomadas, o si, éstas son mejores que las decisiones tomadas siguiendo otros enfoques o métodos (escasa validez). Tercero, los evaluadores pueden equivocarse a la hora de especificar por qué y cómo han llegado a una determinada decisión, lo que hace difícil para otros técnicos cuestionar dicha decisión o determinar la razón del desacuerdo entre los profesionales. Aun así, el enfoque clínico tiene sus ventajas, entre las que destacan la flexibilidad y el énfasis en la prevención de la violencia.

Hay pocas dudas acerca de que el enfoque actuarial sea superior al juicio clínico no estructurado, respecto a la toma de decisiones, y más específicamente respecto a la valoración del riesgo de violencia (Monahan, 1981/1995). Es más, el enfoque actuarial mejora la consistencia y la precisión de la valoración de riesgo. Sin embargo, a pesar del éxito alcanzado en el desarrollo de métodos actuariales para valorar el riesgo de la violencia general (ver Harris, Rice y Quinsey, 1993), y aun existiendo revisiones excelentes de los factores de riesgo asociados con la

delincuencia sexual o con la reincidencia de la violencia sexual (Cooper, 1994; Furby, Weinrott y Blackshaw, 1989; Hall, 1990; Hanson y Bussière, 1996; Hanson, Scott y Steffy, 1995; Proulx, Pellerin, McKibben, Aubut y Ouimet, 1997; Pithers, Beal, Armstrong y Petty, 1989; Quinsey, 1984, 1986), en este momento no hay escalas actuariales desarrolladas para el riesgo de la violencia sexual que estén bien validadas¹. En referencia a esto, quizás las dos escalas actuariales más prometedoras son la *Sex Offender Risk Appraisal Guide* o SORAG (Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995) y la *Rapid Risk Assessment for Sexual Offense Recidivism* o RRASOR (Hanson, 1997).

El SORAG se desarrolló a partir de unos estudios retrospectivos sobre violadores y agresores sexuales infantiles evaluados en un hospital forense de máxima seguridad en Penetanguishene, Ontario (Canadá) (Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995; ver también Quinsey, Rice y Harris, 1995). En la investigación inicial, estos autores identificaron un conjunto de variables socio-demográficas, de historia criminal y clínicas que discriminaban entre los individuos reincidentes y los no reincidentes en una muestra de 178 delincuentes sexuales. También se encontró que el SORAG discriminaba entre aquellos que tenían problemas y los que no durante la libertad condicional, en una muestra de 57 delincuentes sexuales que cumplieron condena y obtuvieron la libertad en varias prisiones federales canadienses (Bélanger y Earls, 1996). Sin embargo, una investigación más reciente en Penetanguishene (Rice y Harris, 1997) indicó un pobre rendimiento de la escala en los estudios de validez cruzada y en consecuencia se revisó la escala para mejorar sus propiedades métricas.

La elaboración del RRASOR fue el resultado de una investigación meta-analítica sobre los predictores de la violencia sexual (Hanson y Bussière, 1996). Hanson (1997), analizó

1. Desde 1997 algunos autores han trabajado al desarrollo de escalas actuariales para delincuentes sexuales. El STATIC-99 (Hanson & Thornton, 1999) existe solamente de factores históricos; el SONAR (Hanson & Harris, 2000) contiene también factores dinámicos. Una comparación de tres instrumentos actuariales para delincuentes sexuales se encuentra en Hanson & Thornton (2000).

una serie de estudios independientes e identificó un pequeño conjunto de variables socio-demográficas y de historia criminal que distinguían a los delincuentes sexuales reincidentes y los no reincidentes. Posteriormente este autor re-analizó los datos de 8 muestras con el objetivo de obtener el mejor método de codificación y de combinación de variables para estimar la precisión predictiva de las puntuaciones totales del RRASOR.

Aunque estos instrumentos son prometedores no hay evidencias, hasta el momento, de que el SORAG y el RRASOR tengan una buena validez predictiva respecto a la violencia sexual. No hay investigaciones publicadas que incluyan la administración de estos tests a delincuentes sexuales que hayan sido puestos en libertad de alguna institución penitenciaria o mental y que hayan determinado la precisión predictiva de dichos instrumentos. Los estudios mencionados en la elaboración del SORAG y del RRASOR probablemente sobreestimaron la precisión predictiva de los mismos (Janus y Meehl, 1997; ver también Hart, 1998a,b), debido al diseño de investigación básica utilizado en el estudio (diseños "post-dictivos" o "retrospectiv") y a los métodos estadísticos utilizados en la elaboración de las puntuaciones algorítmicas (análisis de regresión múltiples).

Los instrumentos actuariales como el SORAG y el RRASOR tienen varias limitaciones (Gottfredson y Gottfredson, 1986; Monahan, 1981/1995). En primer lugar sólo tienen en cuenta un pequeño número de factores de riesgo, que se considera que predicen la violencia en general, ignorando en cambio factores que podrían ser más relevantes aunque idiosincráticos, para el caso de la violencia sexual. Segundo, enfatizan las variables individuales (relativamente) estáticas y estables, como las demográficas y las de historia criminal. Como resultado de ello, las valoraciones realizadas a través de dichos instrumentos actuariales derivan en predicciones pasivas con una limitada utilidad práctica. ¿Cómo se puede intervenir si un individuo presenta riesgo por ser varón? ¿Cómo se pueden evaluar los cambios en el riesgo a lo largo del tiempo si la decisión se basa en sentencias anteriores ya cumplidas? Tercero, debido al énfasis empírico del origen de los instrumentos ac-

tuariales, estas valoraciones pueden incluir factores de riesgo que son inaceptables en el contexto legal y excluir factores que son completamente lógicos pero de validez desconocida (Hart, 1998a, b). Por ejemplo, la construcción empírica de un instrumento actuarial válido, que sea discriminativo incluye factores de riesgo tales como edad, raza y sexo, y también puede incorporar factores que no están relacionados de manera causal con la violencia (por ejemplo, la talla de los zapatos; los hombres suelen ser más violentos que las mujeres y los hombres tienen los pies más grandes que las mujeres), pero suele excluir factores que cualquier persona razonable consideraría relevantes (por ejemplo, ideación homicida o intento de homicidio). En consecuencia las decisiones basadas en este tipo de instrumentos pueden ser difíciles de justificar ante un tribunal. En cuarto lugar, los instrumentos actuariales contruidos con un enfoque empírico son predictores de “alta fidelidad”: se han optimizado con el fin de predecir un resultado específico, para un período de tiempo específico, en una población específica (Gottfredson y Gottfredson, 1986). La aplicación de dicho instrumento a diferentes contextos de valoración puede conducir a decisiones no demasiado precisas, e incluso algunas veces grotescas o extrañas (Hart, 1998b). Finalmente, los instrumentos actuariales existentes predicen la probabilidad de que un individuo cometerá cualquier acto sexual violento. Este énfasis en el aspecto probabilístico del riesgo ignora la naturaleza, la frecuencia, la gravedad y la inminencia del acto violento. Una puntuación que indique que “existe una probabilidad del 10% de reincidencia en un período de 7 años” fracasa en distinguir entre, por ejemplo, un padre que va a mantener un contacto sexual no coercitivo con su hijastra adolescente en los próximos 5 años, *versus* un hombre que secuestrará, mutilará y asesinará a dos chicas jóvenes en los próximos días. Aunque ambos escenarios describen actos de violencia y se pueden considerar equivalentes para algunos propósitos de predicción, existen claras diferencias entre ellos, diferencias que podrían tener implicaciones importantes para las decisiones referidas a la puesta en libertad y control del agresor evaluado.

Aparte de los problemas mencionados, la valoración actuarial del riesgo tiende a que los profesionales se desentiendan del proceso de evaluación. Por su diseño, los instrumentos actuariales son tan estructurados que requieren un juicio profesional mínimo. A menos que los evaluadores tengan una formación suficiente en la teoría psicométrica que justifica las garantías del alcance y limitaciones de los datos del test, los profesionales tienden a hacer una “sobre-utilización” o bien una “sub-utilización” de los datos actuariales en la toma de decisiones sobre los individuos evaluados.

Si debemos evitar el juicio profesional no estructurado, y si no existen escalas actuariales bien validadas, ¿cómo se debería valorar el riesgo de la violencia sexual? Una posibilidad es el juicio profesional estructurado, es decir, evaluaciones de riesgo llevadas a cabo de acuerdo a ciertas directrices explícitas descritas en investigaciones científicas contrastadas y publicadas. Estas directrices pueden mejorar el juicio profesional de varias formas. En primer lugar, las directrices nos permiten realizar evaluaciones de riesgos de manera más sistemática y, por lo tanto, incrementar el acuerdo entre evaluadores. En segundo lugar, al estar derivadas de las investigaciones empíricas, estas directrices pueden mejorar la precisión en las predicciones de violencia. En tercer lugar, las directrices se pueden desarrollar de forma que tengan en cuenta la planificación y elaboración de determinadas intervenciones, como el tratamiento y la supervisión. Finalmente, estas directrices se pueden utilizar en el curso de revisiones rutinarias de control de la calidad de la seguridad o de los incidentes críticos, con el fin de evaluar objetivamente la adecuación de las valoraciones de riesgo.

Este manual comienza con la presentación de cuestiones generales en la valoración del riesgo de la violencia sexual y seguidamente describe un procedimiento de valoración basado en estas directrices, que hemos denominado *Sexual Violence Risk-20* (SVR-20; Riesgo de Violencia Sexual-20). En los últimos años, distintos grupos de trabajo han desarrollado directrices para este tipo de valoraciones del riesgo de violencia aunque todas ellas parecen tener ciertas limitaciones (por ejem-

plo, la *Association for the Treatment of Sexual Abusers*, 1993; el *Colorado Sex Offender Treatment Board*, 1996; Greer, 1991; McGovern y Peters, 1988; McGrath, 1991; Murphy, Haynes y Page, 1992; Ross y Loss, 1991; Revitch y Schlesinger, 1989). Los autores, junto con los Drs. Randy Atkinson y Richard Laws de la *British Columbia Forensic Psychiatric Commission*, desarrollaron unas directrices para los técnicos penitenciarios que se ocupan de la libertad condicional, pero éstas nunca fueron publicadas formalmente (Atkinson, Kropp, Laws y Hart, 1995). Así pues los autores decidieron publicar un conjunto de directrices formalizadas y detalladas, basadas en la experiencia obtenida con la *Spousal Assault Risk Assessment Guide*² (SARA; Kropp, Hart, Webster y Eaves, 1994, 1995) y con el HCR-20 (Webster, Eaves, Douglas y Wintrup, 1995; Webster, Douglas, Eaves y Hart, 1997). Identificaron una lista de factores de riesgo que: (a) tuviesen una relación empírica con la violencia sexual futura, según la evidencia obtenida en las publicaciones científicas y profesionales; (b) fuesen de utilidad práctica, es decir, que permitiesen la toma de decisiones acerca de la gestión institucional y comunitaria de los delincuentes sexuales y que reflejasen los cambios en el estatus de los factores de riesgo dinámicos; (c) que no fueran discriminatorios, es decir, que no incluyeran factores que vulnerasen los derechos humanos o constitucionales, y (d) que fuesen útiles, es decir que el conjunto de factores identificados fuera lo suficientemente extenso para asegurar una comprensión razonable del fenómeno a predecir y, a la vez, lo suficientemente breve como para minimizar la redundancia entre ellos. Además de especificar qué factores de riesgo se deberían valorar, los autores describen cómo se debe realizar la valoración de este tipo de riesgo.

2. Traducida y adaptada al castellano por los autores de esta adaptación y disponible en Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Las directrices aquí presentadas se deben tratar como un primer paso hacia el desarrollo de unos estándares mínimos en la práctica. Estas directrices no son exhaustivas ni fijas. En cualquier valoración pueden aparecer factores específicos del caso que son cruciales para la toma de decisiones acerca del riesgo. Así mismo, a medida que va avanzando la investigación científica, podrían aparecer nuevos factores de riesgo acerca de la violencia sexual, o bien aquellos considerados previamente importantes, podrían demostrar tener una importancia menor a la inicialmente asignada. Teniendo en cuenta esta provisionalidad a continuación se presenta una serie de cuestiones generales acerca de la valoración del riesgo de violencia sexual.

Aspectos genéricos de la valoración

En esta sección se revisan los aspectos mas importantes para la valoración del riesgo de violencia sexual incluyendo: (a) la definición del concepto de violencia sexual; (b) cómo y cuándo llevar a cabo valoraciones del riesgo de violencia sexual; (c) los factores de riesgo básicos a tener en cuenta, y (d) las preguntas claves a realizar a la hora de formular una predicción del riesgo.

Definición de la violencia sexual

A lo largo de este manual entendemos por violencia sexual el intento, la amenaza o el acto real de contacto sexual con una persona que no ha dado su consentimiento o no es capaz de dar su consentimiento.

La definición tiene dos elementos importantes. El primero concierne a la naturaleza del acto. Se considera el contacto sexual de una forma amplia y genérica de tal modo que podemos incluir actos tales como el maltrato sexual (por ejemplo, violación y tocamiento sexual), comportamientos ofensivos de naturaleza sexual (por ejemplo, exhibicionismo, cartas o llamadas de teléfono obscenas, distribución de pornografía), y la violación de los derechos a la intimidad sexual (por ejemplo, voyeurismo, robo de objetos fetiches). El segundo elemento importante se refiere a la víctima. En la mayoría de casos de violencia sexual, las víctimas son conscientes de los actos perpetrados contra su persona, pero no dan su consentimiento a dichos actos. Esto es, la relación o contacto sexual se realiza bajo coacción. En otros casos, las víctimas asienten a dichos actos, pero no tienen capacidad para consentirlos (consentimiento verdadero, completo y legal) por razones de discapacidad mental o de edad. Finalmente, algunas víctimas no pueden dar su consentimiento porque no son conscientes o conocedoras de los actos perpetrados contra su persona (por ejemplo, las víctimas de voyeurismo).

Aunque la definición es amplia y genérica, creemos que es útil. Es similar a aquellas definiciones utilizadas por distintos investigadores y profesionales clínicos y, además, es también consistente con las consideraciones médico-legales que hacen referencia a esta problemática. Así mismo, es importante señalar que aunque es posible descomponer la violencia sexual en distintas categorías específicas (por ejemplo, frotamientos, tocamientos, insultos, agresiones...), se ignora el hecho de que, hasta donde llega nuestro conocimiento, la mayoría de individuos que cometen actos sexuales violentos también ha cometido muchos tipos diferentes de violencia (Abel, Mittleman y Becker, 1985; Abel y Roulcau, 1990; Freund, 1990). Finalmente, hay que destacar que la investigación sobre violencia sexual ha evidenciado que los factores de riesgo relacionados con la reincidencia de un tipo grave de violencia sexual (por ejemplo, violación) también predicen la reincidencia para otros tipos de delitos sexuales (por ejemplo, incesto o abuso infantil).

La realización de valoraciones del riesgo de violencia sexual

La valoración del riesgo difiere de otras formas de evaluación, como la evaluación de los trastornos mentales o la valoración para un tratamiento psicológico, en varios aspectos. Primero, no pertenece al dominio de ninguna disciplina profesional en particular. Por ejemplo, las valoraciones del riesgo se llevan a cabo de manera rutinaria por profesionales penitenciarios, psicólogos y médicos, así como por equipos multidisciplinarios. Segundo, la valoración del riesgo de violencia sexual requiere que los evaluadores estén familiarizados con los factores asociados al crimen y violencia generales, así como con aquellos factores asociados de manera específica con la violencia sexual. Tercero, la valoración de riesgo es intrínsecamente una cuestión forense. En la mayoría de los casos, los evaluadores trabajan directamente para los tribunales o para servicios penitenciarios o de salud mental que asesoran a

los tribunales. En otras situaciones, los evaluadores reconocen que el individuo valorado puede suponer algún riesgo para la seguridad pública y la tarea requiere que los evaluadores hagan un balance entre los derechos del individuo y los derechos públicos. En base a estas y otras consideraciones, sugerimos 6 principios que se deben tener en cuenta para llevar a cabo una valoración del riesgo de violencia sexual. Estos principios se encuentran resumidos en la Tabla 1 y se analizan a continuación con más detalle.

Tabla 1
Las valoraciones del riesgo de violencia sexual

1. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben recoger información acerca del funcionamiento del individuo en múltiples dominios.
2. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben utilizar múltiples métodos de recogida de información.
3. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben recoger información de múltiples fuentes.
4. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben recoger información acerca de factores estáticos y dinámicos.
5. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben evaluar explícitamente la precisión de los datos recogidos.
6. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben repetirse regularmente.

1. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben recoger información acerca de múltiples dominios del funcionamiento del individuo. Tales dominios de funcionamiento incluyen el sexual (p.ej. preferencia sexual o desviación sexual), el intrapersonal (p.ej. actitudes antisociales, trastorno mental, abuso de sustancias), el interpersonal (p.ej. relaciones

íntimas y familiares), el social (p.ej: habilidades sociales, logros educacional y vocacional) y el biológico (p.ej: enfermedad neurológica o endocrina). Este principio reconoce que los delinquentes sexuales violentos son un grupo muy heterogéneo y que la violencia sexual en sí misma es un fenómeno complejo y multifacético. Para un tratamiento extenso de las cuestiones generales en la valoración de delinquentes sexuales, ver Coleman y Dwyer (1990), Colorado Sex Offender Treatment Board (1996), Cooper (1994), Earls (1992), Langevin (1992), Laws y O'Donahue (1997), y Quinsey y Lalumière (1996).

2. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben utilizar múltiples métodos de recogida de información. Los métodos de recogida de datos incluyen entrevistas, observación de la conducta, revisiones de los historiales e informes personales de los casos (por ejemplo, informes médicos, psicológicos y penitenciarios), tests psicológicos (por ejemplo, autoinformes de personalidad y el rendimiento en los tests de inteligencia), evaluaciones fisiológicas (por ejemplo, la fálometría y la poligrafía) y exámenes médicos (por ejemplo, evaluaciones neurológicas y biológicas). Este principio reconoce que cada método de información tiene unas determinadas limitaciones y la excesiva confianza en un método en particular puede conducir a una evaluación incompleta y sesgada sistemáticamente (Colorado Sex Offender Treatment Board, 1996). Las investigaciones publicadas sobre delinquentes sexuales contienen descripciones interesantes acerca de distintos métodos de evaluación específicos (por ejemplo, Abrams, 1991; Association for the Treatment of Sexual Abusers, 1993; Coleman y Dwyer, 1990; Cooper, 1994; Day, Miner, Sturgeon y Murphy, 1989; Farrall, 1992; Freund y Watson, 1991; Langevin, 1992; Murphy, 1990).

3. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben recoger información de múltiples fuentes. Estas fuentes deben incluir, aunque no exclusivamente: el delincuente, la (s) víctima (s), la familia del delincuente y sus amigos y compañeros de trabajo, policías, técnicos penitenciarios y de la salud mental que estén familiarizados con el delincuente. Este principio reconoce que los delinquentes sexuales minimizan

típicamente o niegan sus desviaciones y conductas sexuales anormales (Barbaree, 1991), y que la excesiva confianza en una sola fuente de información también puede dar lugar a una evaluación incompleta y sistemáticamente sesgada (Coleman y Dwyer, 1990; Colorado Sex Offender Treatment Board, 1996; Cooper, 1994; McGovern y Peters, 1988). Esto mismo se recomienda en las evaluaciones forenses más genéricas (Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists, 1991).

4. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben recoger información acerca de factores tanto estáticos como dinámicos. Este principio reconoce que los factores estáticos son los mejores predictores a largo plazo de la violencia sexual, pero también hay que saber que los factores dinámicos pueden estar relacionados de manera fiable con fluctuaciones del riesgo de violencia sexual a corto plazo y, por tanto, son importantes en el desarrollo "racional" de programas de intervención. Esta cuestión se ha considerado relevante en relación al riesgo de violencia sexual, y también en relación con el riesgo para otro tipo de conductas criminales y violentas (Andrews y Bonta, 1994; Kropp et al., 1994, 1995; Quinsey y Walker, 1992; Webster et al., 1994, 1997).

5. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual deben evaluar explícitamente la precisión de los datos recogidos. Este principio reconoce que los evaluadores forenses deben emitir juicios rutinariamente acerca de la credibilidad de diversas fuentes de información, intentar conciliar informaciones contradictorias, y determinar si la información es o no suficientemente comprensible para permitir una toma de decisiones ajustada a la información de que se dispone. Se deben incluir y contrastar en un informe oral o por escrito las decisiones tomadas acerca de la precisión de la información recogida (Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists, 1991; Webster et al., 1994, 1997).

6. Las valoraciones del riesgo de violencia sexual se deben repetir regularmente. Este principio reconoce que el status de los factores de riesgo, tanto los estáticos como los dinámicos, fluctúa en el tiempo (por ejemplo, Colorado Sex

Offender Treatment Board, 1996). En delinquentes que viven en la comunidad, estas fluctuaciones pueden ocurrir de manera bastante rápida, por ello sugerimos que el riesgo de violencia sexual se debe "re-valorar" en intervalos regulares o cuando exista un cambio importante en el estatus del caso.

Factores de riesgo

El SVR-20 incluye un conjunto de 20 factores que, en opinión de los autores deberían ser considerados en cualquier valoración mínimamente completa de riesgo de violencia sexual (ver Tabla 2). Estos factores se identificaron a partir de una revisión exhaustiva de la investigación publicada sobre delinquentes sexuales. Se revisaron numerosos estudios empíricos sobre factores que distinguían entre delinquentes sexuales y delinquentes no sexuales, y sobre aquellos factores que se relacionaban con la reincidencia de la violencia general o de la violencia sexual particularmente en delinquentes sexuales (Furby et al., 1989; Hanson y Brussière, 1996; Prentky, Knight y Lee, 1997; Prentky, Knight, Lee y Cerce, 1995; Quinsey, 1984, 1986; Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995). Así mismo se revisaron las directrices para la valoración de riesgo en violencia sexual que habían propuesto otros autores (Colorado Sex Offender Treatment Board, 1996).

Esta revisión identificó una lista extensa de factores de riesgo. El siguiente paso fue reducir la lista obtenida eliminando aquellos factores que eran redundantes, combinando en un único factor más general distintos factores que estaban relacionados entre sí pero que a la vez eran bastante específicos; y también eliminando ítems que discriminaban por razón de edad, sexo, raza, etc. Como resultado se obtuvieron tres grandes secciones donde incluir estos factores. La primera sección comprende factores relacionados con el funcionamiento psicosocial del individuo. La mayoría de estos factores son de naturaleza biográfica, reflejando características fijas o relativamente estables, mientras que otros factores se refieren al funcionamiento

psicosocial actual y anterior del individuo. Todos los factores de la segunda sección están relacionados con antecedentes individuales de los delitos y/o agresiones sexuales. Una vez más estos factores son mayoritariamente de naturaleza biográfica, aunque algunos contienen también aspectos dinámicos. La tercera sección la constituyen dos factores de riesgo que se interesan por los proyectos de futuro del individuo. Estos factores son inusuales en el sentido que reflejan tanto el funcionamiento actual como el funcionamiento en el pasado. Es interesante señalar que muchos de los factores incluidos en la primera y tercera sección aparecen en muchos procedimientos para la valoración del riesgo de la violencia en general; esto es, estos factores predicen tanto la violencia en general como la violencia sexual en particular. En cambio, los factores de la segunda sección tienden a estar relacionados específicamente con el riesgo de violencia sexual. A continuación se ofrece una breve discusión acerca de los factores de riesgo.

Tabla 2
Principales factores de riesgo de violencia sexual

Funcionamiento psicosocial	
• Desviación sexual	• Relaciones inestables de pareja
• Víctima de abuso en la infancia	• Problemas de empleo / trabajo
• Psicopatía	• Antecedentes de delitos violentos no sexuales
• Trastorno Mental Grave	• Antecedentes de delitos no violentos
• Problemas relacionados con el uso de sustancias tóxicas	• Incumplimiento de las medidas de supervisión previas
• Ideación suicida / homicida	
Agresiones sexuales	
• Delitos sexuales graves	• Progresión en la frecuencia y gravedad de los delitos sexuales
• Tipologías múltiples de los delitos sexuales	• Minimización extrema o negación de los delitos sexuales
• Daño físico hacia la(s) víctima(s) de los delitos sexuales	• Actitudes que apoyan o consenten los delitos sexuales
• Uso de armas o amenazas de muerte en el curso de los delitos sexuales	
Planes de futuro	
• Ausencia de planes de futuro viables	• Actitud negativa hacia la intervención
Otras consideraciones	

Funcionamiento psicosocial. Dos factores reflejan el funcionamiento psicosocial del individuo en este contexto: la desviación sexual y haber sido víctima de abuso en la infancia. La desviación sexual se refiere a la presencia de algún tipo de parafilia, un patrón de excitación sexual anormal y disfuncional. Es importante señalar aquí que no todos los agresores sexuales tienen parafilias y no todas las personas con parafilias son agresores sexuales; sin embargo, las personas con parafilias tienen riesgo de actuar en consonancia con sus impulsos y fantasías sexuales. De hecho, es común que los agresores sexuales tengan parafilias múltiples, incluyendo la excitación sexual en relaciones sexuales violentas y no-consentidas (Abel et al., 1985; Abel y Rouleau, 1990). La presencia de una parafilia se puede inferir a partir de los auto-informes del individuo, de evaluaciones psicofisiológicas, o de un claro patrón de comportamiento sexual desviado. Se ha incluido el factor 'víctima de abuso en la infancia' porque hay evidencia de que la victimación es un factor de riesgo general de la criminalidad y la violencia y, más importante, porque la victimación sexual en la infancia puede predecir la violencia sexual durante la adolescencia y en la edad adulta.

Actualmente se dispone de un cuerpo de conocimientos considerable que apoya la relación entre ciertas formas o síntomas de trastorno mental y la conducta violenta (Monahan y Steadman, 1994). Se han identificado cuatro factores relacionados con el funcionamiento psicológico: Psicopatía, evaluado por el Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; Hare, 1991) o su versión de 'screening' (PCL:SV; Hart, Cox y Hare, 1995); trastorno mental grave, indicado por la presencia de psicosis, manía, retraso mental o discapacidad neuropsicológica grave; problemas relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, incluyendo el abuso de alcohol, drogas de prescripción médica y drogas ilícitas, e ideación suicida/homicida, que incluye impulsos, imágenes e intenciones verbalizadas de dañarse a sí mismo o de dañar a otros. De los cuatro, este último factor tiene el apoyo empírico más débil como predictor de la violencia sexual; sin embargo, puede estar relacionado con la gravedad

(letalidad) de cualquier acto violento futuro, y no sería nada razonable ignorar la ideación homicida cuando se lleva a cabo una valoración de riesgo de violencia.

Dos factores reflejan el fracaso en el funcionamiento adecuado en importantes roles sociales. Las relaciones inestables de pareja se refieren al fracaso por parte del individuo en mantener relaciones íntimas estables y a largo plazo (sexuales y sentimentales). También se incluye el fracaso en el establecimiento de tales relaciones. Los problemas de empleo se refieren al fracaso por parte del individuo en lograr y mantener un trabajo estable. Cuando se evalúan adolescentes, el evaluador deberá considerar la calidad de sus relaciones con su familia de origen en lugar de sus relaciones íntimas, y la estabilidad en su historial educativo más que su historia laboral.

Hay tres factores que reflejan la predisposición del individuo hacia comportamientos antisociales en general y que son también predictores de la violencia sexual: los antecedentes de delitos violentos no sexuales, como por ejemplo robo con violencia, ataque o agresión; antecedentes de delitos no violentos, robo sin violencia o fraude, y el incumplimiento de medidas de supervisión previas, que incluye cumplir y atenerse a las condiciones impuestas por los tribunales o los servicios de justicia criminal, como por ejemplo, quebrantamiento de la libertad provisional, no pagar la fianza, etc. ... Estos factores de riesgo se deben valorar en base a la información obtenida del propio individuo y del historial del caso incluyendo cualquier tipo de informe o registro criminal formal.

Agresiones sexuales. Esta sección está formada por siete ítems relacionados con la violencia sexual previa. El ítem delitos sexuales graves se refiere a la frecuencia de los delitos previos, teniendo en cuenta el período durante el cual el sujeto estaba expuesto al riesgo de cometer un delito o agresión sexual. El ítem tipologías múltiples de delitos sexuales refleja el grado en que un agresor ha atacado a diferentes categorías de víctimas (por ejemplo, hombre vs. mujer, pre o post-púberes vs. adultos, miembros de la familia vs. desconocidos) y ha cometido

agresiones sexuales variadas (por ejemplo, coerción física vs. manipulación psicológica, contacto físico vs. exhibicionismo vs. voyeurismo). Este factor está relacionado presumiblemente con la gravedad de la desviación sexual del individuo. La gravedad del daño físico o psicológico infligido a la víctima de las agresiones sexuales precedentes se ve reflejado por los ítems de daño físico hacia la (s) víctima (s) de la agresión sexual, el uso de armas o amenazas de muerte en el curso de la agresión sexual, y la progresión en la frecuencia o gravedad de las agresiones sexuales. Aunque el apoyo empírico para estos factores es a veces débil, pueden ser buenos predictores de violencia sexual de extrema gravedad y no de la probabilidad de cometer actos violentos. Los últimos dos factores de esta sección tratan dos aspectos psicológicos de la violencia sexual. La minimización extrema o negación de los delitos sexuales puede ocurrir como parte de un patrón más general de desviación de la responsabilidad personal del comportamiento criminal, o puede ser específico de la violencia sexual previa. Las actitudes que apoyan o consienten los delitos sexuales incluyen un amplio rango de creencias o valores —personales, sociales, religiosos, políticos y culturales— que apoyan el patriarcado, la misoginia, o el contacto sexual entre adultos y menores.

Planes de futuro. Esta sección incluye dos ítems que se valoran en base a los proyectos de futuro del individuo valorado. El ítem Ausencia de planes de futuro viables se refiere a la tendencia del individuo a hacer planes de futuro poco realistas, o bien la tendencia a evitar hacer planes de futuro. La actitud negativa hacia la intervención concierne el grado en que el individuo se resiste, es pesimista o no coopera con los programas de evaluación, intervención y supervisión.

Otras consideraciones. En determinados casos pueden aparecer factores cruciales para la conceptualización del riesgo, pero en general no son suficientemente importantes para ser considerados explícitamente en cada evaluación. Estos factores pueden estar relacionados con la probabilidad de que un indi-

viديو cometa un determinado acto sexual violento, tanto por su naturaleza, frecuencia o gravedad como por su inminencia. Por ejemplo, un padre incestuoso que decide mudarse con su familia a una comunidad rural pequeña y aislada podría valorarse como un incremento del riesgo de cometer actos sexuales violentos, aunque el hecho en sí de tener una 'residencia rural' no se incluye como factor de riesgo relevante respecto a la violencia sexual. Los evaluadores deben ser precavidos a la hora de emitir juicios de riesgo basándose en factores que no tienen apoyo empírico y deberán incluir razones persuasivas o convincentes para justificar tal decisión.

Directrices para la toma de decisiones

El estado actual del conocimiento científico y profesional no avala el uso de un procedimiento determinado o de un algoritmo particular para evaluar diferencialmente y combinar las puntuaciones obtenidas con el objetivo de tomar una decisión concreta sobre el riesgo de violencia que sea útil en cualquier contexto. Es probable que, en promedio, las predicciones de riesgo varíen en un sentido positivo y monótono en función del número de factores presentes en cada caso. Sin embargo, parece igualmente probable que la relación entre ambos sea claramente no-lineal, y que el riesgo dependa de una combinación específica de los factores de riesgo presentes y no sólo del número de ellos. Como han propuesto los autores en otras ocasiones (Kropp et al., 1995; Webster et al., 1997), es posible y razonable que los evaluadores concluyan que un individuo tiene un riesgo elevado de cometer actos sexuales violentos basándose en la presencia de un solo factor —por ejemplo, el factor de riesgo ideación suicida/homicida, refleja que el individuo ha manifestado el intento de cometer un homicidio sexual (sorprendentemente, este factor no se contempla en la mayoría de los esquemas de valoración de riesgo actuales disponibles). Así mismo, los evaluadores deben considerar los factores presentes en un caso determinado y tomar una

decisión final sobre el riesgo utilizando su experiencia y juicio profesional.³

La comunicación de los resultados

Si los resultados de la valoración del riesgo no se comunican mediante informes escritos y testimonio oral, tendrán poco o ningún impacto en la toma de decisiones que deben realizar otros profesionales. Es recomendable que cualquier comunicación acerca del riesgo incluya los siguientes elementos, que aparecen resumidos en la Tabla 3.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo cometa un acto de violencia sexual, si no se hacen esfuerzos para minimizar el riesgo? Según la experiencia de los autores es mejor comunicar esta probabilidad como una estimación simple de un riesgo relativo, esto es, en términos de probabilidad baja, moderada o alta, relativa a grupos de pacientes o de delincuentes sexuales. También puede ser útil disponer de información acerca de la prevalencia de reincidencia para periodos de tiempo determinados del grupo de comparación. La probabilidad de riesgo se debe justificar con referencia a la presencia o ausencia de varios factores de riesgo en el caso al que hace referencia la predicción.

2. ¿Cuál es la naturaleza, frecuencia y gravedad probables de cualquier acto de violencia sexual futura? En la mayoría de los casos, se asume que cualquier comportamiento violento futuro reflejará el nivel de los delitos anteriores. Sin embargo, esta presuposición puede ser insostenible si el individuo ha cometido tipos de delitos variados en el pasado, o si la valoración de riesgo ofrece una buena razón para creer que

3. Es probable que sumando simplemente el número de factores presentes para alcanzar una puntuación numérica y aplicando un punto de corte estándar maximice la precisión predictiva en su conjunto. Sin embargo, contrariamente a Grove y Micheli (1996), los autores creen que no sería razonable, ético ni legal que los profesionales tomen decisiones utilizando tal procedimiento, esto es, sin considerar la totalidad de las circunstancias que se den en cada caso concreto.

la "trayectoria" de violencia sexual del individuo podría estar cambiando (Greenland, 1985). Quizás lo más importante es considerar la posibilidad de que el individuo cometa actos de violencia múltiples o graves, tales como la violación sistemática, la agresión sádica o el homicidio sexual.

Tabla 3
Cuestiones a tener en cuenta en la toma de decisiones
Acerca del riesgo de violencia sexual

1. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo cometa un acto de violencia sexual, si no se hacen esfuerzos para minimizar el riesgo?
2. ¿Cuál sería la naturaleza, frecuencia y gravedad probables de cualquier acto violento futuro?
3. ¿Cuáles serían las víctimas probables de cualquier acto sexual violento futuro?
4. ¿Qué pasos hay que seguir para reducir el riesgo de violencia sexual del individuo?
5. ¿Qué circunstancias pueden exacerbar el riesgo del individuo de cometer un acto sexual violento?

3. ¿Quiénes serían las víctimas probables de la violencia sexual futura? En algunos casos es posible identificar víctimas potenciales por su nombre, o bien por la relación que mantienen con el agresor o por el rol que juegan en las fantasías sexuales del agresor. En el caso en que esto no sea posible, cualquier información acerca de la preferencia de las víctimas puede ser útil para aquellos que deban tratar al agresor mientras esté viviendo en la comunidad.

4. ¿Qué pasos hay que seguir para reducir el riesgo de violencia sexual del individuo? A la luz de los factores de

riesgo presentes en cada caso, el evaluador debe hacer sugerencias concretas y prácticas acerca de la reducción de riesgo. Éstas pueden incluir recomendaciones relativas a las sentencias de reclusión, lugar de residencia, tratamiento psiquiátrico o psicológico, entrenamiento vocacional, supervisión de la libertad condicional, etc. Dada la escasez de información actual acerca de la eficacia de la elaboración de programas para agresores sexuales, los evaluadores deben ser precavidos y no hacer promesas explícitas o implícitas acerca de que las intervenciones recomendadas reducirán el riesgo.

5. ¿Qué circunstancias pueden aumentar el riesgo del individuo de cometer una agresión sexual? Una vez más, los factores de riesgo presentes en cada caso permiten al evaluador identificar algunas "señales de advertencia" de que, si ocurren, los profesionales que se ocupan del caso consideren una "re-valoración" formal del riesgo.

Un "informe de riesgo" ajustado a las directrices que acabamos de presentar se muestra en la Tabla 4. Este ejemplo se ha extraído de una valoración para considerar la libertad condicional del Sr. Smith (pseudónimo), de 45 años de edad que está cumpliendo una condena de 60 meses por agresión sexual a un menor ya que se acerca la fecha de su puesta en libertad. El informe realizado resume la información biográfica del caso y muestra los factores de riesgo presentes; así mismo la tabla presenta la valoración y decisión final de riesgo de violencia sexual.

Tabla 4
La comunicación de los resultados: ejemplo de un "informe de valoración de riesgo"

Basándome en una valoración global y comprensiva del riesgo que comporta la puesta en libertad, o no, del Sr. Smith, en mi opinión, el mencionado Sr. Smith muestra un alto riesgo de cometer violencia sexual en comparación con el grupo de referencia de otros agresores internados en prisión. Los estudios de seguimiento indican que cerca del 10% de los agresores sexuales encarcelados son arrestados por cometer nuevas agresiones sexuales en un periodo de un año desde su puesta en libertad; en los 10 años posteriores a la puesta en libertad, la proporción aumenta hasta un 35%. En mi opinión, la probabilidad de reincidencia del Sr. Smith es sustancialmente mayor que estas estimaciones.

De acuerdo con la información disponible todos los delitos sexuales del Sr. Smith son de naturaleza pedofílica, incluyendo tocamientos sexuales no coercitivos a niños jóvenes con los que entraba en contacto de manera casual. No hay información disponible que me lleve a creer que la naturaleza y gravedad de sus delitos cambiarán en el futuro. Basándome en sus delitos anteriores, si el Sr. Smith reincide sus víctimas tenderán a ser mayoritariamente niños de entre 6 y 12 años de edad que viven unos kilómetros alrededor de la residencia del Sr. Smith.

Dada su larga historia de delitos y la naturaleza de la parafilia del Sr. Smith, ésta es resistente al tratamiento y la forma más eficaz de reducir el riesgo de violencia sexual es a través de la incapacitación, esto es, denegando su solicitud de la libertad condicional. Si se excarcela al Sr. Smith, las estrategias de reducción del riesgo se deberán centrar en la supervisión intensiva. Estrategias de supervisión eficaces podrían ser la monitorización electrónica, visitas frecuentes del funcionario encargado de supervisar la libertad condicional, pruebas poligráficas y el tratamiento psicológico para la desviación sexual¹. En las condiciones de excarcelación se deberá estipular que el Sr. Smith no deberá quedarse a solas con ningún niño y mantenerse apartado de los patios de las escuelas, parques, o cualquier lugar público frecuentado por niños. Si el Sr. Smith empieza de nuevo a abusar del alcohol, o si fracasa en la obtención de un empleo a jornada completa, su riesgo de cometer actos sexuales violentos puede verse exacerbado y deberá ser re-valorado lo más pronto posible.

(Nota a la edición española)

La heterogeneidad de los delincuentes sexuales y datos de reincidencia

Al final del capítulo todavía algunos comentarios sobre las grandes diferencias en porcentajes de reincidencia dentro el grupo de delincuentes sexuales. Hanson & Bussière (1998) a partir de un extenso meta-análisis (N=28.972) encontraron que, para un periodo medio de seguimiento entre 4 y 5 años, el 13,4% de los delincuentes sexuales volvía a delinquir sexualmente. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta aspectos tales como si los agresores han recibido tratamiento, el tipo de agresores y la duración del seguimiento. Quinsey, Lalumière, Rice & Harris (1995) encontraron en base a un meta-análisis (17 estudios, N=4483) un porcentaje medio de reincidencia (nueva condena) por abuso del 20,4% (rango: 4% hasta 38%), mientras que la de violencia sexual contra mujeres era del 22,8% (rango: 10% hasta 36%). En el caso de abuso sexual contra menores, los que abusaron de niños muestran una reincidencia media del 35,2%, y los que abusaron de niñas una reincidencia media del 18,3%. En casos de incesto reincidieron, en promedio, un 8,5%. Alexander (1995) comparaba dos grupos de autores de delitos sexuales contra menores varones, un grupo había recibido tratamiento otro no. Los agresores que no recibían tratamiento reincidieron, en promedio, un 34,1% y los que habían recibido tratamiento volvía a reincidir un 18,2%. Hanson, Steffy & Gauthier (1993) calcularon que el 1,8% de los agresores sexuales infantiles reincidieron, tras un primer periodo de seguimiento de 5 años y durante un periodo de 20 años. Los violadores reincidieron más pronto, independientemente del efecto del tratamiento, comparado con autores de delitos de pedofilia. Estos últimos suelen obtener más beneficio del tratamiento cognitivo pero el riesgo de reincidencia se mantiene durante un periodo más largo (20 años). (Obtenido de: Hildebrand, M., de Ruiter, C. & van Beck, D. (2001). Los estudios de reincidencia realizados en España reflejan una tasa de reincidencia oficial (nuevos delitos que comportan ingreso en prisión) de los delincuentes sexuales no-tratados del 18,1% (Redondo, Navarro Martínez, Luque y Andrés, 2005) y del 19,4% (Luque, Ferrer y Capdevila, 2005).

SVR-20
Hoja de codificación (ejemplo)

Evaluación de:	
Nombre:	Edad:

Especificar periodo de tiempo en que se evalúa el Cambio reciente:

Funcionamiento psicosocial

	Presencia (N, ?, S)	Cambio reciente (+, 0, -)
1. Desviación sexual	☐	☐
2. Víctima de abuso en la infancia	☐	☐
3. Psicopatía	☐	☐
4. Trastorno mental grave	☐	☐
5. Problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas	☐	☐
6. Ideación suicida / homicida	☐	☐
7. Problemas interpersonales	☐	☐
8. Problemas de empleo / laborales	☐	☐
9. Antecedentes de delitos violentos no sexuales	☐	☐
10. Antecedentes de delitos no violentos	☐	☐
11. Fracaso en las medidas de supervisión previas	☐	☐

Delitos sexuales		
12. Frecuencia elevada de delitos sexuales	☐	☐
13. Tipología múltiple de delitos sexuales	☐	☐
14. Daño físico a la (s) víctima(s) de los delitos sexuales	☐	☐
15. Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexuales	☐	☐
16. Progresión en la frecuencia y gravedad de los delitos sexuales	☐	☐
17. Minimización extrema o negación de los delitos sexuales	☐	☐
18. Actitudes que apoyan o justifican los delitos sexuales	☐	☐

Planes de futuro

19. Carencia de planes realistas
20. Actitud negativa hacia la intervención

Otras consideraciones

Codificación resumen del riesgo

1. Riesgo de violencia sexual

Bajo Moderado Alto

Evaluación llevada a cabo por:

Nombre: _____ Título: _____

Firma: _____ Fecha: _____

SVR-20

El SVR-20

El SVR-20

En el capítulo anterior se ha resumido la visión actual acerca de cómo se deben llevar a cabo las valoraciones profesionales del riesgo de violencia sexual. A continuación se presenta un procedimiento específico para la valoración del riesgo de violencia sexual, el SVR-20, basado en los principios generales descritos en las páginas anteriores.

Formato

El SVR-20 es un método o procedimiento de valoración del riesgo de violencia sexual, no es un test psicológico ni un cuestionario psicológico. Aunque es un intento de sistematizar la evaluación de los individuos, no está suficientemente estructurado ni estandarizado para ser un test y no genera puntuaciones normativas o criterios. Existen otros procedimientos similares para el uso en diferentes ámbitos de la evaluación psico-legales, que se ajustan al término "Instrumentos de Evaluación Forense" (Grisso, 1986).

Aplicaciones

El SVR-20 se ha desarrollado, principalmente, para su aplicación en las valoraciones de riesgo de violencia sexual en contextos forenses, tanto penales como civiles. Su uso es apropiado en los casos en que un individuo ha cometido o presuntamente ha cometido un acto sexual violento. También se puede aplicar el SVR-20 para propósitos distintos a la valoración del riesgo, incluyendo la educación, el "entrenamiento", el control de calidad y las revisiones de incidentes críticos. A continuación presentamos un resumen de las posibles aplicaciones.

Con antelación al juicio. Cuando las personas son arrestadas por delitos relacionados con la violencia sexual, la naturaleza de sus presuntos actos o sus antecedentes pueden suscitar la pregunta de si se les deniega la libertad previa al juicio bajo la asunción de que presentan un riesgo inminente de dañar a

personas ya sean identificables o anónimas, o qué tipo de condiciones se deben establecer para la libertad previa al juicio a fin de minimizar o reducir el riesgo percibido.

Aplicación previa a la sentencia. A veces se requieren valoraciones de riesgo, solicitadas por la defensa, cuando se está juzgando el caso. Si todavía no ha sido sentenciado, los resultados pueden servir de ayuda a los jueces que estén considerando la libertad condicional o no del defendido. Si ya ha sido declarado culpable, los resultados pueden ayudar a los jueces a decidir entre varias sentencias alternativas (libertad vigilada *versus* prisión), y para elaborar o recomendar condiciones para otras medidas comunitarias (realización de tratamiento establecido por el tribunal, supervisión poligráfica).

Admisión en centro penitenciario/psiquiátrico. Después de la sentencia, las valoraciones de riesgo pueden servir de ayuda a los técnicos penitenciarios. Se pueden utilizar para la elaboración de programas de tratamiento, así como para determinar la adecuación o las condiciones para establecer las visitas familiares, permisos temporales, etc.

Excrcelación. En el caso de agresores encarcelados, las valoraciones de riesgo pueden ayudar a los técnicos penitenciarios o a las comisiones de libertad condicional a determinar la adecuación o las condiciones para la libertad condicional, así como en la evaluación en el marco de un tratamiento o programa de prevención de recaídas. Para un agresor residente en la comunidad que está finalizando el periodo de supervisión, una valoración final del riesgo puede ayudar a los profesionales penitenciarios en la comunicación formal de posibles advertencias sobre individuos que tienen riesgo, con el fin de resolver obligaciones éticas y legales previas a cerrar el caso oficialmente.

Cumplimiento de condena indeterminado (aplicable en la legislación canadiense y norteamericana). En otros países, no en España, se han establecido estatutos y normas para el

cumplimiento de penas (penales o civiles) de duración indeterminada para agresores sexuales "peligrosos" o de "alto riesgo", también etiquetados como "depredadores sexuales violentos". En estos procedimientos la valoración del riesgo tiene una gran importancia. Se puede utilizar para determinar si un individuo cumple los criterios requeridos para el cumplimiento de la condena o si una vez que ha concluido la condena es idóneo para salir en libertad vigilada, o para establecer las condiciones de supervisión que le serán impuestas y más allá de la puesta en libertad. En España y en los países latinoamericanos, aunque no existen condenas indeterminadas, la legislación penal y penitenciaria prevee algunas figuras que pueden comportar la excrcelación temporal de los reclusos, o, como el régimen abierto o la libertad condicional, suponen un acortamiento efectivo de las penas de prisión. Por las mismas razones a la hora de conceder o no al sujeto un permiso penitenciario o de concederle la libertad provisional, es de la máxima importancia efectuar una valoración de su nivel de riesgo de violencia y reincidencia.

Jurisdicción Civil/Familiar. Actualmente se ha incrementado el reconocimiento de la violencia familiar en el ámbito de la justicia civil. Obviamente, si un padre ha cometido violencia sexual en el pasado, pueden ponerse en duda sus aptitudes parentales. Además las evaluaciones de custodia deberían incluir valoraciones del riesgo de violencia sexual cuando existan dudas o acusaciones previas de este tipo de delitos.

Control de calidad y revisión de incidentes críticos. Como hemos dicho antes, el SVR-20 resume el conocimiento y la experiencia profesional y científica en el área de la valoración del riesgo de violencia sexual. Los autores han hecho un gran esfuerzo para asegurar que los ítems incluidos en el SVR-20 sean de fácil comprensión (incluyendo definiciones concretas y claras), acordes con los derechos constitucionales y otros similares (de modo que no discriminen en base a la edad, sexo, etnia u otros motivos), sean de utilidad práctica (puedan ser cumplimentados en base a una evaluación competente y rigurosa).

rosa) y tengan validez científica (hayan demostrado una fuerte asociación con la violencia). El SVR-20 puede ser utilizado por profesionales de la salud mental, personal de prisiones, juristas y abogados de las víctimas para evaluar el rigor y la calidad de las valoraciones de riesgo llevadas a cabo por otros técnicos de dos maneras. En primer lugar planteándose una cuestión como la siguiente: ¿Ha fallado el evaluador en reconocer o valorar cada factor de riesgo que aparece en el SVR-20? El SVR-20 no es exhaustivo, en el sentido de que hay numerosos factores específicos no incluidos en el instrumento que pueden estar asociados al riesgo de violencia sexual. Sin embargo, el SVR-20 contiene un conjunto de factores básicos o mínimos que deben ser considerados en todos los casos. Segundo preguntándose: ¿Ha considerado el evaluador otros factores no incluidos en el SVR-20? Aunque el SVR-20 no es exhaustivo, parece justo y razonable que se pida a los evaluadores que fundamenten de manera clara sus juicios sobre tales factores.

Limitaciones

No se puede utilizar el SVR-20 para determinar si alguien ha cometido un acto de violencia sexual en el pasado, ni para determinar si alguien "encaja en el perfil de agresor sexual", dado que tal perfil no existe. Los factores de riesgo incorporados en el SVR-20 están relacionados con el riesgo de violencia futura en individuos que ya han cometido un delito o agresión sexual.

El SVR-20 se diseñó para realizar valoraciones del riesgo de violencia sexual. No se puede utilizar para valorar el riesgo de conductas criminales no violentas, violencia no-sexual, ni otras formas específicas de violencia como, por ejemplo, la violencia en la pareja y el acoso. Si existe alguna evidencia de que el individuo evaluado presenta riesgo de conductas antisociales, más que de violencia sexual específicamente, se debe prestar atención a este problema más genérico y considerar el incluirlo en la valoración del riesgo objeto del informe.

Habilidades del usuario

La administración y codificación adecuadas del SVR-20 requieren habilidades profesionales y de formación importantes. Los usuarios de este instrumento deberán poseer, como mínimo, las siguientes habilidades:

1. Formación especializada en la realización de evaluaciones individuales. Los usuarios deben estar entrenados y tener experiencia en la realización de entrevistas, administración e interpretación de tests estandarizados y en el diagnóstico de los trastornos mentales.

2. Formación especializada en el estudio de la violencia sexual. Los usuarios deben estar familiarizados con las publicaciones profesionales y científicas acerca de la naturaleza, causas y tratamiento de la violencia sexual.

El grado de formación especializada requerida en estas áreas depende del propósito con el que se utilice el SVR-20, así como de las leyes aplicables, regulaciones y políticas del contexto en el que se va a aplicar. Cuando se utiliza el SVR-20 con propósitos clínicos—esto es, para la toma de decisiones acerca de la ubicación, tratamiento o manejo de un individuo— los usuarios deberán poseer un nivel alto de formación especializada (estudios universitarios de postgrado u otra formación especializada, experiencia práctica tutorizada) y deberán tener los requisitos y credenciales profesionales (registro, licencia u otro título legal para llevar a cabo una evaluación individual). Cuando se aplica el SVR-20 con objetivos de investigación, se puede administrar por personas que no poseen una formación completa. Sin embargo, estas personas deben estar bajo la supervisión de usuarios que tengan una formación completa, los cuales asumen la responsabilidad del tratamiento ético de los participantes de la investigación.

Diversos ítems del SVR-20 evalúan factores que están directamente relacionados con los trastornos mentales. Los usuarios que carezcan de las credenciales necesarias para llevar a cabo evaluaciones psicodiagnósticas no están legalmente

autorizados para codificar estos ítems, excepto en las siguientes circunstancias:

1. Los ítems son codificados bajo supervisión de profesionales acreditados.
2. Los ítems son codificados en referencia a los resultados de evaluaciones psicodiagnósticas existentes.
3. Los ítems son codificados de manera provisional, con la anotación de que dicha codificación debe ser confirmada por un profesional acreditado.
4. Los ítems son omitidos en su totalidad, con una anotación acerca de cómo su omisión ha afectado la decisión final de riesgo.

En algunos contextos, la responsabilidad de llevar a cabo las evaluaciones puede estar distribuida entre varios profesionales diferentes. Por ejemplo, es posible que un psiquiatra explore la posible existencia de trastornos mentales graves, que un psicólogo evalúe los trastornos de personalidad y el funcionamiento intelectual, que una enfermera, un trabajador social o un funcionario de prisiones evalúen los planes de exarcelación. Es aceptable e incluso deseable, que el SVR-20 se aplique en base a informes realizados por distintos profesionales de manera dependiente. Sin embargo, para objetivos clínicos, el usuario en una formación completa en habilidades profesionales debe responsabilizarse de cotejar la información e intentar consensar las decisiones finales referentes a cada ítem del protocolo.

Procedimiento de evaluación

Cuando se lleva a cabo una valoración de riesgo, cómo se recoge la información es tan importante como qué información se recoge. No se debe completar el SVR-20 hasta haber sido a cabo una valoración detallada; los ítems se codifican o si se ha recogido y sopesado toda la información disponible. En general, la evaluación debe incluir múltiples fuentes de información así como múltiples métodos de recogida de información, incluyendo: (a) entrevistas con el individuo y con

su(s) víctima(s); (b) administración de medidas estandarizadas de comportamiento sexual, desviación sexual, educación y actitudes sexuales, uso/abuso de sustancias y psicopatología; (c) evaluaciones fisiológicas, por ejemplo, las médicas, poligráficas y pletismográficas, y (d) revisiones de registros colaterales, por ejemplo los informes policiales, declaraciones de la(s) víctima(s) o testigos, registros criminales y los informes médicos o de salud mental. (Las recomendaciones acerca de la valoración de los factores de riesgo específicos se presentan en la siguiente sección.)

La amplitud y profundidad de las valoraciones variarán en función del contexto. Por ejemplo, las valoraciones llevadas a cabo con objetivos clínicos deben realizarse con un nivel más alto de exhaustividad que las que tienen como finalidad la investigación. Sin embargo, incluso para objetivos clínicos, no es necesario ni posible llevar a cabo una valoración exhaustiva en cada caso. En lugar de ello, los usuarios deben intentar llevar a cabo una valoración que sea comprensible. Por ejemplo, a la luz de la tendencia a minimizar y negar comportamientos sexuales desviados, no sería razonable basar la valoración de riesgo en los auto-registros no corroborados del individuo evaluado. Así mismo, tampoco sería razonable, en la mayoría de las circunstancias, omitir una entrevista con el individuo. En cambio, los evaluadores pueden decidir de manera razonable no entrevistar a la(s) víctima(s) si tienen acceso a las transcripciones de entrevistas anteriores.

Como parte de toda valoración de riesgo, los evaluadores deben considerar la exhaustividad y la calidad de la información recogida en la valoración. Se debe dar a conocer cualquier limitación importante de la información recogida durante la valoración, mediante informes escritos o testimonios orales. Además, los evaluadores deberán calificar sus conclusiones y recomendaciones de acuerdo con dichas limitaciones.

Codificación

La codificación del SVR-20 requiere que los evaluadores emitan dos tipos de juicios. Primero, a nivel de ítems, los eva-

luidadores deben comprobar la presencia o ausencia de cada uno de los 20 factores de riesgo individuales (así como de cualquier otro factor de riesgo existente en cada caso concreto). En caso de presencia, los evaluadores deben indicar si ha habido algún cambio reciente en el estatus del factor de riesgo en cuestión, esto es, si se ha convertido en un factor al que se debe prestar más o menos atención (si se ha intensificado el riesgo o por el contrario se ha atenuado) o bien si ha permanecido invariable. Segundo, los evaluadores deben integrar la información a nivel de ítem para formular un juicio o decisión final acerca del riesgo de violencia.

Presencia. Los ítems se codifican en una escala de 3 puntos, de acuerdo con la certeza de que los factores de riesgo estén presentes o lo han estado en algún momento en el pasado. La "N" indica que, de acuerdo a la información recogida durante la valoración, el factor de riesgo está ausente (o, dicho de otra manera, no hay información que sugiera que el factor de riesgo está presente). La "?" indica que el factor de riesgo está posiblemente o parcialmente presente; esto es, la información indica que hay alguna evidencia de su presencia, aunque la evidencia no sea del todo concluyente. La "S" indica que el factor de riesgo está claramente presente y de forma indiscutible. Si no hay ninguna información disponible sobre un ítem en particular, o si se considera que la información disponible no es en absoluto fiable, se puede codificar el ítem con una "O", indicando que se ha omitido la decisión con respecto a este ítem. Esta opción no debe utilizarse para indicar la incertidumbre acerca de la presencia o no de un ítem (que sería codificado con una "?"). El esquema de codificación se resume en la Tabla 4.

Tabla 4
La codificación de la presencia de los factores de riesgo

N	No — El factor de riesgo está ausente, no es aplicable o no hay evidencia alguna, a partir de la evaluación realizada según la cual podamos concluir que el factor de riesgo está presente.
?	Puede — El factor de riesgo está posiblemente presente o está presente de manera limitada.
S	SI — El factor de riesgo está presente.
O	Omisión — Hay una carencia total de información que permita decidir acerca de la presencia o ausencia del factor de riesgo.

Cambio reciente. Cuando se ha codificado un factor de riesgo como definitivamente presente ("S"), los evaluadores deben indicar si ha habido un cambio reciente en el estatus del factor. Esta información puede ser de ayuda en las valoraciones clínicas a fin de priorizar estrategias de control del riesgo y para determinar si el riesgo global del individuo parece incrementarse o disminuir en el tiempo (es decir, atender a los aspectos dinámicos del riesgo).

Los cambios "recientes" son aquellos que han ocurrido a lo largo del año anterior al momento de la evaluación. Sin embargo para cada valoración puede cambiar este intervalo temporal (por ejemplo, en los últimos 5 años, en los últimos 6 meses). Para evitar confusión, el periodo temporal utilizado en la valoración se deberá documentar en todas las comunicaciones, incluso en los formularios de codificación. El formulario de codificación del SVR-20 (se presenta al final de este manual a modo de ejemplo) proporciona un ejemplo de cómo se puede hacer esto.

Un "cambio en el estatus" se puede relacionar con el incremento o reducción del riesgo y esto puede acontecer de formas diversas. En los ejemplos más claros, un factor de riesgo puede cambiar de "presente a ausente" o de "ausente a presente". Por ejemplo, un individuo puede haber empezado a abusar del alcohol de manera importante en los últimos nueve meses

(incremento en el ítem 5); puede haber sido puesto en la lista de espera para el tratamiento de la desviación sexual (reducción del ítem 20); o haber tenido una progresión repentina y reciente en su patrón de agresión sexual (incremento en el ítem 16).

Los cambios recientes se codifican de la siguiente manera: "+" indica incremento, exacerbación o empeoramiento de un factor de riesgo; "0" indica que no ha ocurrido ningún cambio reciente en el estatus del factor; y "-" indica reducción o mejora del factor de riesgo. Este esquema se resume en la Tabla 5.

Resumen de las puntuaciones de riesgo. Los autores recomiendan que los evaluadores codifiquen una puntuación final o resumen del riesgo de violencia sexual, utilizando una escala de 3 puntos (ver ejemplo de la hoja de codificación del SVR-20 al final de este manual): "Bajo" indica que el evaluador considera que el individuo o bien no presenta riesgo, o bien presenta un riesgo muy bajo de cometer actos de violencia sexual; "Moderado" indica que el evaluador considera que el individuo tiene un riesgo moderado o cierto riesgo de cometer actos de violencia sexual y "Alto" indica que el evaluador considera que el individuo muestra un riesgo elevado o muy elevado de cometer actos de violencia sexual. A pesar de que pueden parecer medidas muy simples, este tipo de codificación es fácilmente comprensible por otros profesionales que deban tomar decisiones al respecto y se puede traducir en distintos modos de actuar (ver Monahan y Steadman, 1996). Las acciones tomadas dependerán del contexto en el que se aplique la valoración y de la disponibilidad de recursos. En general, un juicio de bajo riesgo sugiere que el individuo no necesita ninguna intervención en especial ni acciones de supervisión diseñadas para reducir el riesgo de violencia, y que no hay necesidad de "supervisar" al individuo de cerca para detectar posibles cambios en el nivel de riesgo. Un juicio de riesgo moderado sugiere la elaboración de un programa de reducción del riesgo para el individuo. Este programa debe incluir, como mínimo, algún mecanismo para la re-valoración sistemática del riesgo. Un juicio de alto riesgo sugiere la necesidad urgente de elaborar un programa de reducción del riesgo para el individuo, que implicaría (como mínimo)

personas que lo controlen, niveles de supervisión progresiva, inclusión del individuo en una lista de máxima prioridad para los recursos de tratamiento y la planificación regular de re-valoraciones. Algunos casos de alto riesgo requerirán una respuesta urgente de actuación (hospitalización, suspensión de la libertad condicional).

Tabla 5. La codificación de cambios recientes en el estatus de los factores de riesgo

+	Aumento — Recientemente el factor de riesgo ha empeorado (ahora está presente o se ha exacerbado)
0	No Cambio — Recientemente no ha habido cambio alguno en el status del factor de riesgo.
-	Reducción — Recientemente el factor de riesgo ha mejorado (ahora está ausente o ha mejorado).

Como se presentó en el capítulo anterior, no es posible especificar un método único y preciso para alcanzar un juicio o decisión final que sea útil en cualquier caso. Para la investigación, es posible otorgar al SVR-20 el tratamiento de escala actuarial y hacer simplemente una suma del número de factores de riesgo presentes, puntuando de 0 a 20, ignorando cualquier factor de riesgo específico del caso incluido en el apartado "Otras Consideraciones". Si se omiten ítems, se deberá prorratear la puntuación total. El prorrateo no es recomendado cuando se omiten muchos ítems —es decir, más de 5 ítems en total. Tampoco recomendamos la ponderación diferencial de los ítems individuales, ya que no existen evidencias de que este procedimiento mejore la precisión predictiva de manera fiable (Dawes, 1982); no obstante, la ponderación puede ser interesante o importante en una investigación determinada.

Para objetivos clínicos, tiene poco sentido sumar el número de factores de riesgo presentes en un caso determinado y luego utilizar puntos de corte fijos y arbitrarios para clasificar al individuo en la categoría de riesgo bajo, moderado o alto. Es

posible y razonable para el evaluador concluir que el individuo muestra un alto riesgo de cometer actos de violencia sexual basándose en la presencia de un solo factor de riesgo —por ejemplo, si, tal factor de riesgo refleja el intento manifiesto del individuo de cometer un homicidio o de actuar en base a fantasías sexuales sádicas actuales (ítem 6). De manera similar, los rasgos psicopáticos extremos (ítem 3) pueden obligar al evaluador a concluir que el individuo presenta un alto riesgo (Hart, 1998a, b). Algunos factores, como por ejemplo discapacidad física, puede llevar a la conclusión de que el individuo está en bajo riesgo.⁴

La ausencia de factores de riesgo parecen indicar que la valoración del riesgo no es necesaria, sin embargo conviene mencionar que, en promedio, los juicios de riesgo varían positiva y monotónicamente como una función del número de ítems presentes en cada uno. Dicho de una forma más sencilla es razonable que los evaluadores concluyan que a mayor número de factores presentes en un caso, mayor será el riesgo de violencia. Sin embargo incluso en dicha situación, los evaluadores deben tener cuidado. La relación entre el número de factores de riesgo presentes y el riesgo de violencia es probablemente y específicamente no-lineal; el riesgo depende probablemente, no sólo del número sino también de la combinación específica de los factores de riesgo presentes. En definitiva, en el momento presente no parece posible ni deseable desarrollar puntos de corte para las decisiones finales sobre el riesgo en el contexto clínico.

Los ítems omitidos son un problema importante. El prorrateo asume que los ítems del SVR-20 son homogéneos, esto es, que las correlaciones entre ellos son positivas y muy similares entre sí en cuanto a magnitud. Esta asunción puede ser

4. Los evaluadores deben tener precaución en concluir que alguien con discapacidad no es capaz de cometer actos de violencia. Se conocen muchos casos de personas discapacitadas que han cometido actos violentos graves, incluyendo un hombre en silla de ruedas que cometió violación y otro hombre ciego que convenció a otra persona para que cometiera un asesinato por él. Aún más, algunas lesiones —como el daño cerebral de origen traumático— podrían de hecho incrementar el riesgo de violencia (Bowman, 1997).

errónea. Por lo tanto, para los objetivos clínicos, "O" (omisión) debe ser considerada igual que "N" (ausente), ambas calificaciones indican que no hay información disponible que lleve a sugerir que un factor de riesgo está presente. Los evaluadores deben reconocer, sin embargo, que los ítems omitidos pueden afectar negativamente la validez de la predicción del riesgo, particularmente si el juicio emitido es que el individuo presenta un riesgo bajo de cometer actos de violencia sexual. Cuando los ítems se califican como omitidos, los evaluadores deben ajustar sus opiniones en concordancia con este hecho justificando cómo sus opiniones podrían cambiar si dispusiera de una información más completa sobre el factor omitido.

Re-valoraciones

El riesgo de violencia no es una característica estable de los individuos. El estatus de los factores individuales y el riesgo de violencia general fluctúan en el tiempo, a veces de manera intensa. Por ejemplo, la exacerbación de un solo factor de riesgo (por ejemplo, ítem 6) puede cambiar la decisión final del evaluador y cambiar de "bajo" a "alto" riesgo. Un solo incidente de violencia sexual puede modificar muchos ítems. Consideremos el caso de un hombre cuyas conductas sexuales previas conocidas se limitan al voyeurismo pero que ha intentado agredir sexualmente a una mujer con un arma mientras está en un permiso penitenciario; la re-valoración puede llevar a modificar los ítems 1, 12, 13, 14 y 15.

La importancia de la re-valoración reside en que permite a los responsables de la supervisión del caso considerar cambios en las estrategias de control e intervención. Así mismo, la re-valoración puede ayudar a los evaluadores a caracterizar el progreso de un individuo, positivo o negativo, durante la supervisión.

Los intervalos de tiempo entre valoraciones de riesgo se determinan en base a tres consideraciones. La primera la constituyen las normas legales vigentes aplicables. La segunda es si el

individuo reside en la comunidad o en una institución. En general, el riesgo debe ser valorado más frecuentemente en el primer caso que en el segundo. Si un individuo está cumpliendo una larga condena de reclusión, sería innecesario valorar anualmente el riesgo. La tercera y última consideración es el nivel global de riesgo del individuo. Como el seguimiento es una importante estrategia de reducción del riesgo, los altos niveles de riesgo deben ir acompañados de frecuentes valoraciones. Para un nivel bajo de riesgo, se recomiendan valoraciones formales cada 6 ó cada 12 meses o cuando exista un cambio importante en el status del caso. Para aquellos con un riesgo global moderado, la re-valoración debe ser más frecuente —cada dos semanas, cada mes, o cada dos meses para aquellos con un riesgo global alto, la re-valoración se debe llevar a cabo cada semana, cada dos semanas, o cada mes.

El proceso de llevar a cabo una re-valoración formal debe ser similar a aquél llevado a cabo en la valoración inicial, en la medida en que el evaluador tenga acceso a entrevistas, información de la historia del caso, etc. Sin embargo, la re-valoración debería implicar considerablemente menos tiempo. Si el evaluador tiene un contacto habitual con el individuo, podría ser innecesario llevar a cabo nuevas entrevistas; también podría ser innecesario renovar/poner al día la información histórica del caso o llevar a cabo una evaluación pletismográfica. En tales casos, la re-valoración puede consistir simplemente en que los evaluadores re-codifiquen cada ítem y la puntuación global del riesgo de acuerdo con la información actualizada.

Documentación de los resultados

Tanto en las valoraciones clínicas como en la investigación se requiere documentación clara y concisa. Los hallazgos que estén documentados inadecuadamente pueden ser inservibles y carecer de todo valor. Los evaluadores deben registrar los resultados utilizando protocolos estandarizados. Hemos considerado que se puede utilizar un formulario para documen-

tar la mayor parte del proceso de valoración de manera simple y rápida.

Al final de este manual se presenta un formulario, a modo de ejemplo, de la "hoja de codificación del SVR-20". Este formulario incluye una sección de registro de información básica de la valoración, incluyendo nombres y fechas; una sección para codificar la presencia de factores de riesgo individuales y cualquier cambio reciente en el estatus de los mismos, y una sección para codificar el nivel global del riesgo. Desde una perspectiva clínica, tales formularios facilitan enormemente la elaboración de informes escritos. Desde una perspectiva legal, ayudan a establecer el modo como el evaluador ha llevado a cabo una valoración determinada. Una versión más detallada del formato de codificación está disponible en la compañía que publica y distribuye esta prueba, Psychological Assessment Resources, Inc. (En España se puede obtener en el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona o en el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia).

Definición de los factores de riesgo

Los 20 ítems del SVR-20 están divididos en tres secciones. La mayoría de los ítems de la sección "Funcionamiento psicosocial" son históricos (biográficos) y reflejan aspectos fijos o estables, mientras que los ítems restantes se refieren al funcionamiento actual de los sujetos.

1. Desviación sexual

Justificación

La desviación sexual —también conocida como preferencia sexual desviada o parafilia— es un patrón relativamente estable de arousal sexual hacia estímulos inadecuados (por ejemplo, edades inapropiadas, personas que no dan o no pueden dar su consentimiento, animales u objetos inanimados) que causa angustia o disfunción social (American Psychiatric Association, 1994).

La relación entre desviación sexual y violencia sexual es intensa (fuerte) y probablemente causal, aunque indirecta: no todas las personas con preferencias sexuales anómalas cometen actos de violencia sexual y no todas las personas que cometen actos de violencia sexual tienen una desviación sexual. Sin embargo, los estudios científicos indican que los individuos cuya violencia sexual está motivada, al menos en parte, por una desviación sexual tienen un riesgo mayor de reincidencia en este tipo de comportamientos violentos. Esto se ha observado independientemente de si la desviación sexual es inferida a partir de la historia del comportamiento sexual del agresor, de los resultados de las evaluaciones pletismográficas de la excitación sexual desviada, o de los auto-registros de las fantasías y cogniciones sexuales anómalas del agresor (Hanson y Bussière, 1996).

La desviación sexual es probablemente un factor de riesgo causal que convierte a la violencia sexual en algo atractivo para algunos individuos. Dependiendo de su naturaleza la desviación sexual, se relaciona con diversas facetas del riesgo. Generalmente las personas con desviaciones sexuales cometen actos de violencia que son consistentes con sus fantasías. Así mismo, las parafilias graves y múltiples, y también las específicas, están relacionadas con la probabilidad, la frecuencia y la minuciosidad de la violencia sexual futura, del mismo modo que el sadismo sexual (excitación sexual provocada por el sufrimiento físico o psíquico de otros) puede predecir la gravedad de los actos violentos futuros.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo, en cualquier momento de su vida, ha padecido una desviación sexual.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo, en cualquier momento de su vida, ha padecido una desviación sexual.
No	No existe evidencia de que el individuo, en cualquier momento de su vida, haya padecido una desviación sexual.

Notas

La "Desviación Sexual" es un patrón relativamente estable de excitación sexual anormal (excitación por estímulos inadecuados), esté o no dentro del contexto de los delitos sexuales. Es importante señalar que la excitación no tiene por qué ser aceptada o ser deseable para el individuo (egosintónico); es suficiente con que él o ella tengan experiencias de excitación sexual anormales. La evidencia acerca de la desviación sexual proviene típicamente de diversas fuentes: entrevistas clínicas o poligráficas; cuestionarios de auto-registro; comportamiento anterior; información de fuentes colaterales (por ejemplo, registros de casos, miembros de la familia) y evaluación pletismográfica.

La desviación sexual se puede inferir a partir del comportamiento. Sin embargo tales inferencias son probablemente más precisas cuando están basadas en un patrón de comportamiento, más que en un único suceso.

2. Víctima de abuso en la infancia

Justificación

La evidencia empírica sugiere que el abuso en la infancia es un factor de riesgo general de criminalidad, violencia no sexual y sexual (Dutton y Hart, 1992a,b; Kaufman y Zigler, 1989; Widom, 1989), incluso para los agresores sexuales (Hanson y Bussière, 1996). Las revisiones profesionales también apoyan la consideración del abuso infantil a la hora de evaluar el riesgo de cometer actos de violencia sexual (Greer, 1991; McGovern y Peters, 1988; Ross y Loss, 1991). Sin embargo, hay poca evidencia que apoye una relación específica entre el abuso sexual en la infancia y la violencia sexual posterior/en la edad adulta (Hanson y Bussière, 1996; Romans, Martin y Mullen, 1997).

Numerosas teorías socio-psicológicas y biopsicológicas predicen una relación estrecha entre las experiencias de abuso en la infancia y la perpetración de la violencia en la edad adulta. Las teorías socio-psicológicas tienden a ver el abuso infantil como un factor causal, mientras que las teorías bio-psicológicas lo ven como un marcador de riesgo. Algunas teorías también ponen de manifiesto que las experiencias de abuso sexual en la infancia están relacionadas de manera causal con la violencia sexual en la edad adulta, posiblemente por su influencia en el desarrollo de preferencias sexuales desviadas (ver Laws y O'Donohue, 1997; Marshall, Laws y Barbaree, 1990). Es probable que el abuso infantil esté relacionado tanto con la naturaleza como con la probabilidad de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo fue víctima de abuso físico grave, abuso sexual o negligencia en su infancia.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo fue víctima de abuso físico grave, abuso sexual o negligencia en su infancia.
No	No hay evidencia de que el individuo fue víctima de abuso físico grave, abuso sexual o negligencia durante la infancia.

Notas

El término "grave" significa que el abuso o negligencia ha dado como resultado un daño físico o psicológico sustancial, o que ocurrió en diversas ocasiones.

El "abuso físico" incluye todo intento o amenaza de violencia no sexual, o bien su comisión real; el "abuso sexual" incluye todo intento o amenaza de violencia sexual, o bien su comisión real. Es irrelevante quién haya cometido inculcado tal abuso (familia, conocidos, iguales o desconocidos).

La "negligencia" incluye el fracaso de los responsables en satisfacer las necesidades vitales (alimentación, vestido, cuidados de salud, higiene) a quienes dependen de ellos y la exposición de estos a la violencia familiar (por ejemplo, permitiendo a los niños presenciar agresiones entre la pareja parental).

El término "infancia" se refiere a un menor dependiente. El término "dependiente" significa que el menor todavía vive en o se ha fugado de la casa parental (similar); un menor es aquel que tiene una edad igual o menor a 17 años (NT: en la legislación canadiense y en USA. En España la legislación penal considera menor, a efectos de poder sufrir abusos sexuales, a los menores de 13 años y en ciertos supuestos a los menores de 16 años (NT).

3. Psicopatía

Justificación

La Psicopatía —también conocida como trastorno de personalidad psicopático, antisocial o disocial— es un factor importante de riesgo de criminalidad y de violencia en delinquentes penitenciarios y pacientes psiquiátricos forenses (Hart y Hare, 1997). Respecto a la violencia sexual, la psicopatía está relacionada con agresiones pasadas, oportunistas y sádicas (Hart y Hare, 1997). Los estudios de seguimiento de los agresores sexuales indican que la psicopatía es tanto un predictor de criminalidad general, como de violencia no sexual y de violencia sexual (Hanson y Brüssière, 1996; ver también Rice y Harris, 1997).

Parece que la psicopatía tiene una relación causal con todas las facetas del riesgo de violencia (Hart y Dempster, 1997). Por ejemplo, los psicópatas exhiben motivaciones tanto instrumentales como reactivas para cometer actos violentos (Cornell et al., 1996). Además, la psicopatía probablemente está relacionada con la tendencia, frecuencia, gravedad e inminencia de la violencia sexual futura. Para una comprensión más detallada del papel de la psicopatía en la valoración de riesgo de violencia, ver Hart (1998a,b), Webster et al. (1997) y Hildebrand, de Ruiter & de Vogel, (2004).

Las versiones del PCL-R están traducidas por el Dr. R. Torrubia y en fase de publicación en castellano. Aunque haya suficiente investigaciones que sugieren que la psicopatía es un trastorno de validez trans-cultural (Grann, 1998), también se sabe que el punto de corte en países distintos de los EE UU es más bajo. Recomendamos usar este ítem con cuidado.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha padecido un trastorno de personalidad psicopática, en algún momento de su vida.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha padecido un trastorno de personalidad psicopática, en algún momento de su vida.
No	No hay evidencia de que el individuo ha padecido un trastorno de personalidad psicopática, en algún momento de su vida.

Notas

El "trastorno de personalidad psicopática" hace referencia a la psicopatía definida según el PCL-R o PCL:SV. La investigación indica que los inventarios de auto-registro no se pueden utilizar para diagnosticar este trastorno de manera fiable. Así mismo, los evaluadores no deben utilizar los criterios diagnósticos del trastorno de personalidad antisocial de la cuarta edición del Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994), los cuales carecen de especificidad en el contexto forense.

El PCL-R y el PCL:SV se deben administrar, puntuar e interpretar de acuerdo con las instrucciones de los manuales de dichos instrumentos (Hare, 1991; Hart et al., 1995). En el PCL-R las puntuaciones de 30 ó superiores indican la presencia de psicopatía; las puntuaciones comprendidas entre 21 y 29 indican la presencia posible o parcial de psicopatía, y las puntuaciones de 20 ó inferiores indican la ausencia de psicopatía. Los puntos de corte correspondientes al PCL:SV son 18 y superiores; entre 13 y 17, y 12 e inferiores⁵.

5. En Catalunya y por indicación del Departament de Justícia (responsable del régimen penitenciario) se utilizan como puntos de corte de la PCL:SV los rangos 18-24 y 12-17 para identificar la presencia segura o probable, respectivamente de psicopatía.

4. Trastorno mental grave

Justificación

La investigación epidemiológica en diversos países indica que los trastornos mentales graves, aquellos que deterioran gravemente la cognición y la afectividad, están relacionados con el incremento del riesgo de criminalidad y violencia (Hodgins, 1992; Monahan, 1992). Podría haber una relación particularmente intensa entre la violencia y la psicosis o la manía (Douglas y Hart, 1996; McNeil y Binder, 1994; Taylor et al., 1994). Existe alguna evidencia de que la psicosis y los déficit intelectuales también son factores de riesgo de la violencia sexual (Hanson y Brüssière, 1996), y las revisiones profesionales recomiendan incluirlos en la valoración de riesgo (McGovern y Peters, 1988; Murphy et al., 1992).

El trastorno mental grave probablemente es un factor causal de decisiones impulsivas o irracionales para actuar de manera sexualmente violenta. Así mismo el trastorno mental está asociado a la posible violencia sexual futura, y también los síntomas activos de un trastorno mental grave pueden estar relacionados con la inminencia de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha padecido un trastorno mental grave en algún momento de su vida.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha padecido un trastorno mental grave en algún momento de su vida.
No	No hay evidencia de que el individuo ha padecido un trastorno mental grave en algún momento de su vida.

Notas

El "trastorno mental grave" incluye un deterioro cognitivo o intelectual severo (por ejemplo, demencia, retraso mental); trastornos psicóticos (por ejemplo, esquizofrenia, trastorno delirante); y trastornos afectivos mayores (por ejemplo, depresión mayor, trastorno bipolar). Los diagnósticos se deben llevar a cabo de acuerdo a criterios estandarizados (por ejemplo, aquellos contenidos en el DSM-IV).

5. Problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas

Justificación

El consumo de sustancias está relacionado con un incremento del riesgo de violencia general (Hodgins, 1990; Swanson, 1994). También, ha sido vinculado al riesgo de violencia sexual tanto en estudios experimentales (Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995) como en revisiones profesionales (McGovern y Peters, 1988; Murphy et al., 1992). El consumo de sustancias también puede predecir la criminalidad general en los agresores sexuales (Hanson y Brüssière, 1996).

No obstante, la naturaleza de relación entre el consumo de sustancias y la violencia sexual no está clara. Este factor podría ser simplemente un marcador de riesgo, señalando indirectamente la presencia de un trastorno de personalidad u otro funcionamiento psicosocial inadecuado. También hay propuestas que consideran que el consumo de sustancias tóxicas podría ser un factor causal.

Quizás el consumo de sustancias se traduce en una tendencia incrementada a la desinhibición comportamental entre los individuos con patrones de excitación sexual desviados; o aquellos con una desviación sexual grave podrían consumir sustancias deliberadamente con el fin de desinhibir la violencia sexual. En cualquier caso el consumo de sustancias probablemente está relacionado con la probabilidad y frecuencia de la violencia sexual futura, así como con su naturaleza (por ejemplo, motivaciones reactivas o impulsivas para cometer actos sexuales violentos; Cornell et al., 1996). Así mismo el consumo activo de sustancias puede estar relacionado con la inminencia de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha tenido problemas graves de consumo de sustancias en algún momento de su vida.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha tenido problemas graves de consumo de sustancias en algún momento de su vida.
No	No hay evidencia de que el individuo ha tenido problemas graves de consumo de sustancias en algún momento de su vida.

Notas

El "consumo de sustancias" incluye el consumo de drogas ilícitas, así como el consumo inadecuado de sustancias lícitas (alcohol, fármacos prescritos).

Los "problemas graves" incluye el abuso de sustancias y la dependencia; esto es, el consumo de sustancias que lleva a un deterioro sustancial de la salud o del funcionamiento social del individuo (por ejemplo, sobredosis, enfermedad física, arresto policial, pérdida de empleo).

6. Ideación suicida/homicida

Justificación

Las ideas y pensamientos de causar daño tanto a uno mismo como a otros, son muy relevantes en la valoración del riesgo. De hecho, la ideación/intento suicida y homicida están típicamente considerados en la legislación de la salud mental con el fin de constituir los fundamentos para la incapacitación psiquiátrica involuntaria (NI, en la legislación canadiense). Aunque parezca sorprendente, existen pocas evidencias empíricas que indiquen que las amenazas o pensamientos específicos de infligir daño sean predictores fiables de violencia, y tampoco se analizan habitualmente en las revisiones profesionales. Esto puede ser debido a que la ideación suicida u homicida no se expresa frecuentemente o bien porque puede fluctuar mucho con el paso del tiempo.

Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de desviación sexual y, particularmente, de sadismo sexual (ítem 1), de trastorno mental grave (ítem 4), o de actitudes que apoyan o consienten la violencia sexual (ítem 18). Una historia de ideación suicida u homicida probablemente esté relacionada con la probabilidad, frecuencia y gravedad de violencia sexual futura; la naturaleza de la ideación con la naturaleza de la violencia, y la ideación reciente con la inminencia del comportamiento violento.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha tenido problemas graves relacionados con la ideación suicida u homicida en algún momento de su vida.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha tenido problemas graves relacionados con la ideación suicida u homicida en algún momento de su vida.
No	No hay evidencia de que el individuo ha tenido problemas graves relacionados con la ideación suicida u homicida.

Notas

La "ideación suicida u homicida" incluye pensamientos, impulsos y fantasías acerca de causar — así como la intención o los intentos de causar— daño grave o muerte a uno mismo o a otros.

El término "grave" significa (a) que la ideación es vivida de manera persistente e intrusiva, o implica métodos altamente letales; o, (b) que el nivel de la intención está comprendido entre moderado y alto.

La ideación suicida u homicida se puede inferir a partir del comportamiento. Tales inferencias serán probablemente más precisas en la medida en que estén basadas en un patrón de comportamiento, más que en una sola conducta.

7. Problemas en las relaciones sentimentales de pareja

Justificación

Los agresores internos en las instituciones penitenciarias y los pacientes forenses que tienen relaciones íntimas inestables tienden a tener historiales criminales más extensos, mayor frecuencia en la comisión de delitos violentos y un índice mayor de reincidencia general y violenta que aquellos que tienen relaciones íntimas estables (Andrews y Bonta, 1994; Zinder y Fruchman, 1981). El fracaso en el establecimiento y mantenimiento de relaciones íntimas estables también es considerado un factor de riesgo importante de violencia sexual (Hanson, 1997; Hanson y Brussière, 1996; McGovern y Peters, 1988; Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995). En la evaluación de niños y adolescentes, es más adecuado considerar la estabilidad de las relaciones familiares (padres, cuidadores, hermanos/as), que de las relaciones íntimas; esta recomendación es consistente con las revisiones profesionales (Greer, 1991; Murphy et al., 1992) y con la investigación (Hanson y Brussière, 1996).

Los problemas en las relaciones sentimentales e íntimas pueden ser un marcador de riesgo, predictor de la violencia sexual por su relación con los trastornos de personalidad o con la desviación sexual grave. Estos problemas también pueden estar vinculados a la violencia sexual de manera causal por la restricción que supone de las oportunidades del individuo de tener relaciones sexuales adecuadas (lícitas). Así, una historia de problemas en las relaciones íntimas puede estar relacionada con la probabilidad y frecuencia incrementadas de violencia sexual futura, y los problemas recientes con la inminencia de la violencia sexual.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha fracasado en establecer y mantener relaciones íntimas (sexuales) estables.
?	Evidencia posible/percibida de que el individuo ha fracasado en establecer y mantener relaciones íntimas (sexuales) estables.
No	No hay evidencia de que el individuo ha fracasado en establecer y mantener relaciones íntimas (sexuales) estables.

Notas

"Relaciones íntimas (sexuales)" significa relaciones conyugales y de hecho según las leyes vigentes, relaciones entre adultos. Tales relaciones implican una expectativa de convivencia, monogamia y compromiso a largo plazo. Carece de importancia si la pareja es de naturaleza heterosexual u homosexual.

El término "estable" significa que la historia del individuo no se caracteriza por múltiples rupturas o por conflicto conyugal grave, incluyendo la violencia en la pareja.

Si un individuo es un menor dependiente, este ítem se debe codificar en base a la estabilidad de las relaciones con su familia de origen.

8. Problemas de empleo

Justificación

Los problemas de empleo están relacionados con el riesgo de criminalidad y de violencia general (Andrews y Bonta, 1994; Harris et al., 1993; Menzies y Webster, 1995; Monahan, 1981/1995), y también con el riesgo de violencia sexual (McGovern y Peters, 1988; Ross y Loss, 1991). En la evaluación de niños y adolescentes, puede ser adecuado considerar la estabilidad escolar en lugar de la estabilidad en el empleo.

Como sucede con los problemas tratados en el apartado de los problemas de pareja los problemas de empleo pueden ser un marcador de riesgo que produce la violencia sexual por su relación con los trastornos de personalidad o con la desviación sexual grave. De manera alternativa, los problemas de empleo pueden estar vinculados a la violencia sexual de manera causal por el incremento de la angustia psicológica general, que muchas veces lleva al aumento esporádico de pensamientos o impulsos sexuales desviados (Proulx et al., 1997). Así, una historia previa de problemas de empleo pueden estar relacionados con un incremento en la probabilidad y frecuencia de violencia sexual futura, y los problemas recientes con la inminencia de la violencia sexual.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha fracasado en establecer y mantener un empleo estable.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha fracasado en establecer y mantener un empleo estable.
No	No hay evidencia de que el individuo ha fracasado en establecer y mantener un empleo estable.

Notas

El término "empleo" significa un empleo legal (incluyendo el empleo autónomo), así como la educación y la formación relacionados con el empleo. Como este ítem se interesa por la adaptación del individuo en la comunidad, cualquier empleo, educación o formación que el individuo recibe mientras reside en una institución penitenciaria o psiquiátrica es de poca relevancia.

El término "estable" significa que el individuo no tiene una historia previa de cambios frecuentes de empleo ni períodos largos de desempleo.

Si el individuo es un menor dependiente, este ítem se debe codificar en base a la estabilidad de su historia educativa previa.

9. Antecedentes de delitos violentos no sexuales

Justificación

La violencia no sexual es un factor de riesgo de criminalidad y violencia en los delincuentes y pacientes forenses (Harris et al., 1993; Monahan, 1981/1995), incluyendo los agresores/delincuentes sexuales (Hanson y Brussière, 1996; Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995). En el momento actual, no hay evidencia clara de que éste sea un factor de riesgo específico de violencia sexual (Hanson y Brussière, 1996). Según las revisiones científicas profesionales existentes, la violencia no sexual previa es un factor importante a tener en cuenta en las valoraciones clínicas de riesgo (Murphy et al., 1992; Ross y Loss, 1991).

Este factor podría ser un marcador de riesgo que refleje la presencia de trastorno de personalidad o actitudes antisociales. Posiblemente esté relacionado con la probabilidad, frecuencia y gravedad de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo tiene antecedentes de violencia no sexual grave.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo tiene antecedentes de violencia no sexual grave.
No	No hay evidencia de que el individuo tenga antecedentes de violencia no sexual grave.

Notas

El término "violencia" implica daño físico real, intencionado o amenaza hacia otra persona. Las amenazas incluyen verbalizaciones y conductas de inducción del miedo que implican claramente el uso potencial de violencia por parte del individuo.

El término "grave" significa que la violencia ha causado (o tenía el potencial de causar) daño sustancial físico o psicológico a la víctima, o que sucedió en diversas ocasiones.

El término "no-sexual" significa que la violencia no incluyó contacto o comunicación real, intencionada o amenaza de naturaleza sexual ni con el fin de llevar a cabo una agresión sexual.

A la hora de codificar este ítem, los evaluadores deben considerar los auto-informes y los informes de fuentes colaterales fiables, además del registro penal del individuo. Así mismo, se deben tener en cuenta los actos de violencia no sexual graves que ocurren mientras el individuo reside en un servicio psiquiátrico o penitenciario.

10. Antecedentes de delitos no violentos

Justificación

Los antecedentes criminales generales (no sexuales y no violentos) son un factor de riesgo de violencia y de violencia sexual en los delincuentes y pacientes forenses (Harris et al., 1993; Monahan, 1981/1995), incluyendo los agresores sexuales (Hanson y Brussière, 1996; Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995). Según las revisiones científicas profesionales existentes, los delitos no violentos previos son un factor importante a tener en cuenta a la hora de realizar valoraciones clínicas de riesgo (McGovern y Peters, 1988; Murphy et al., 1992; Ross y Loss, 1991).

Este factor podría ser un marcador de riesgo que refleja la presencia de trastorno de personalidad o actitudes antisociales. Posiblemente esté relacionado con la probabilidad y la frecuencia de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo tiene antecedentes de conducta criminal no violenta y no sexual graves.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo tiene antecedentes de conducta criminal no violenta y no sexual graves.
No	No hay evidencia de antecedentes de conducta criminal no violenta y no sexual graves.

Notas

La "conducta criminal" significa comportamiento antisocial o cualquier acto que constituya una violación de las leyes penales vigentes.

El término "grave" significa que la conducta criminal dio como resultado (o podría haber dado como resultado) denuncia o detención, o que ocurrió en diversas ocasiones.

El término "no-violento" significa que la conducta criminal no incluyó daño físico real, intencionado o amenaza a otra persona.

El término "no-sexual" significa que la conducta criminal no incluyó contacto o comunicación real, intencionada o amenaza de naturaleza sexual y que no había intención de cometer una agresión sexual.

A la hora de codificar este ítem, los evaluadores deben tener en cuenta los auto-informes e informes de fuentes colaterales fiables, así como del registro criminal formal del individuo. Así mismo, se debe considerar la conducta delictiva no violenta grave que ocurre mientras el individuo reside en un servicio psiquiátrico o penitenciario.

11. Fracaso en las medidas de supervisión previas

Justificación

Las personas que han violado las condiciones de la libertad condicional o de la supervisión comunitaria (NT: u otras medidas penales similares) tienen un riesgo incrementado de delinquir y de cometer actos violentos (Bonta, Harman, Hann y Cormier, 1996; Harris et al., 1993). Estos hechos pueden considerarse también un factor de riesgo de violencia sexual y no sexual en agresores sexuales (Rice y Harris, 1997; Quinsey, La-lumière, Rice y Harris, 1995). Según las revisiones científicas y profesionales, el fracaso en las medidas de supervisión previas puede ser un factor importante a considerar a la hora de realizar valoraciones clínicas de riesgo (McGovern y Peters, 1988).

Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de trastorno de personalidad, así como de desviación sexual y actitudes que apoyan o consienten la violencia sexual (si los fracasos en las medidas implican actos de violencia sexual). Posiblemente esté relacionado con la probabilidad, frecuencia e inminencia de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo tiene antecedentes graves en la violación de las condiciones mientras se encuentra bajo supervisión comunitaria.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo tiene antecedentes graves en la violación de las condiciones mientras se encuentra bajo supervisión comunitaria.
No	No hay evidencia de antecedentes graves en la violación de las condiciones mientras el individuo se encuentra bajo supervisión comunitaria.

Notas

La "supervisión comunitaria" significa que el individuo ha estado residiendo en la comunidad de acuerdo a normas judiciales civiles o penales (por ejemplo, orden bajo fianza, orden de restricción, cumplimiento del tratamiento ambulatorio, o que se la ha concedido la libertad condicional en un servicio de salud mental o penitenciario o un pase de día o permiso).

Las "violaciones graves" incluyen cualquier acto de violencia sexual o no sexual, conducta delictiva grave, fuga e infracciones técnicas de las condiciones que han llevado (o podrían haber llevado) a la revocación de la puesta en libertad o denuncias por actos delictivos.

A la hora de codificar este ítem, los evaluadores deben considerar los auto-informes y los informes provenientes de fuentes colaterales fiables, además del registro delictivo formal del individuo.

Ítems con referencia a delitos sexuales

Los ítems que se agrupan en esta sección de 'delitos sexuales' hacen referencias a los antecedentes sexuales de los sujetos. Los ítems son principalmente de tipo biográfico y de naturaleza histórica, aunque algunos ítems incluyen aspectos dinámicos.

12. Frecuencia elevada de delitos/agresiones sexuales

Justificación

El número de delitos sexuales cometidos en el pasado es uno de los factores relacionados de un modo más fiable con la reincidencia de violencia sexual en los internos penitenciarios y pacientes forenses (Hanson, 1997; Hanson y Brüssière, 1996; Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995). Según las revisiones científicas profesionales existentes este es un factor importante a incluir en las valoraciones clínicas de riesgo (McGovern y Peters, 1988; Murphy et al., 1992; Ross y Loss, 1991).

Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de desviación sexual y de actitudes que apoyan o consenten la violencia sexual. Posiblemente esté relacionado con la probabilidad, frecuencia e inminencia de la violencia sexual futura. Así mismo, la naturaleza de los delitos previos puede estar asociada con la naturaleza y gravedad de la violencia sexual futura.

Codificación

SI	Evidencia de que el individuo ha cometido actos de violencia sexual frecuentes, mientras ha estado bajo riesgo de cometerlos.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha cometido actos de violencia sexual frecuentes, mientras ha estado bajo riesgo de cometerlos.
No	No hay evidencia de que el individuo haya cometido actos de violencia sexual frecuentes, mientras ha estado bajo riesgo de cometerlos.

Notas

El término "frecuente" significa múltiples actos de violencia sexual y que han ocurrido en un periodo relativamente corto de tiempo. Este juicio se debe basar en la ocurrencia de toda forma de violencia sexual cometida por el individuo, así como en el conocimiento profesional acerca de la prevalencia en que tal violencia se comete en el entorno social del sujeto.

"Mientras ha estado bajo riesgo de cometerlos" significa que durante ese periodo el individuo ha tenido la oportunidad de cometer actos de violencia sexual. Esto se refiere generalmente, aunque no exclusivamente, a momentos en que la persona evaluada ha residido en el seno de la comunidad.

A la hora de codificar este ítem, los evaluadores deben considerar los auto-informes e informes procedentes de fuentes colaterales fiables, además del registro delictivo formal del individuo.

13. Tipos múltiples de delitos sexuales

Justificación

Las personas que han cometido diferentes y variados tipos de delitos sexuales tienen un riesgo incrementado de reincidencia en violencia sexual (Hanson, 1997; Hanson y Brüssière, 1996; Quinsey, Lalumière, Rice y Harris, 1995). Se considera que es importante tener en cuenta este factor a la hora de llevar a cabo una evaluación clínica del riesgo (McGovern y Peters, 1988; Murphy et al., 1992; Ross y Loss, 1991). Las "tipologías" de delito sexual se definen típicamente de acuerdo a las características de las víctimas y a la naturaleza de la violencia.

Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de desviación sexual, así como de actitudes que apoyan o consienten la violencia sexual. Podría estar relacionado con la probabilidad, frecuencia e inminencia de la violencia sexual futura; por otra parte podría avanzar el pronóstico de la naturaleza específica y la gravedad de cualquier acto futuro de violencia sexual.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha cometido tipos múltiples de delitos sexuales.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha cometido tipos múltiples de delitos sexuales.
No	No hay evidencia de que el individuo haya cometido tipos múltiples de delitos sexuales.

Notas

"Tipos múltiples de delitos sexuales" significa que la historia del individuo incluye actos delictivos que varían en su naturaleza y en el tipo de víctimas. La naturaleza del delito sexual varía a través de diversas dimensiones, incluyendo el tipo y grado de contacto con la víctima (por ejemplo, voyeurismo versus exhibicionismo versus violación/agresión sexual) y la naturaleza y grado de coerción utilizada (por ejemplo, amenazas con un arma versus tortura). La selección de la víctima varía a través de dimensiones tales como la edad (por ejemplo, niños prepúberes versus adolescentes versus adultos de la tercera edad), sexo (por ejemplo, niños versus niñas) y relación (por ejemplo, cónyuge versus extraños).

A la hora de codificar este ítem, los evaluadores deben tener en cuenta los auto-informes y los informes procedentes de fuentes colaterales fiables, así como el registro delictivo formal del individuo.

14. Daño físico a la(s) víctima(s) de los delitos sexuales

Justificación

No hay una evidencia clara de que este factor sea predictivo de la violencia sexual (Hanson y Brüssière, 1996; ver Epperson, Kaul y Huot, 1995). Sin embargo, este factor de riesgo particular es difícil de estudiar, porque los individuos que cometen actos de violencia física más grave normalmente están institucionalizados durante periodos de tiempo más largos comparados con la mayoría de delinquentes sexuales. Las revisiones científicas lo han considerado un factor importante a tener a cuenta en las valoraciones clínicas de riesgo (Greer, 1991; McGovern y Peters, 1988; Murphy et al., 1992; Ross y Loss, 1991).

Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de desviación sexual (posiblemente sadismo sexual), así como actitudes que apoyan o consenten la agresión sexual. Podría estar relacionado con la probabilidad, frecuencia y la gravedad de la violencia sexual; también podría estar asociado a la naturaleza de cualquier acto violento sexual futuro.

Codificación

SI	Evidencia de que el individuo ha causado daño físico grave a la (s) víctima (s) mientras cometía delitos de violencia sexual.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha causado daño físico grave a la (s) víctima (s) mientras cometía delitos de violencia sexual.
No	No hay evidencia de que el individuo haya causado daño físico grave a la (s) víctima (s) mientras cometía delitos de violencia sexual.

Notas

El "daño físico" significa que la víctima ha sufrido lesión corporal —moretones/magulladuras, abrasiones, cortes, etc.— como resultado directo de las acciones de un individuo que o bien tenía la intención deliberada de causar daño físico o bien se comporta de manera desconsiderada con el daño ocurrido en su caso.

"Grave" significa que el daño físico requiere atención médica o tratamiento, o que ha provocado como resultado, la muerte de la víctima.

"Mientras cometía" significa durante un acto de violencia sexual o que precedió al delito sexual.

A la hora de codificar este ítem los evaluadores deben tener en cuenta los auto-registros y los registros provenientes de fuentes colaterales fiables, además del registro delictivo formal del individuo. Los informes médicos pueden ser particularmente útiles.

15. Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexuales

Justificación

No existe una evidencia clara de que este factor sea predictivo de la violencia sexual (Hanson y Brussière, 1996). Sin embargo, este factor es difícil de estudiar porque los individuos que emplean armas a la hora de delinquir pasan periodos de tiempo más largos en las instituciones penitenciarias que la mayoría de agresores sexuales. Las revisiones clínicas han considerado la importancia de este factor a la hora de realizar valoraciones clínicas de riesgo (Greer, 1991; McGovern y Peters, 1988; Ross y Loss, 1991).

Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de desviación sexual (posiblemente sadismo sexual), así como de actitudes que apoyan o consienten a violencia sexual. También, podría estar relacionado con la naturaleza, probabilidad, frecuencia y gravedad de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha utilizado armas o ha amenazado de muerte mientras cometía actos de violencia sexual.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha utilizado armas o ha amenazado de muerte mientras cometía actos de violencia sexual.
No	No hay evidencia de que el individuo haya utilizado armas o ha amenazado de muerte mientras cometía actos de violencia sexual.

Notas

Las "armas" incluyen armas de fuego, navajas, porras, cuerdas o cualquier otro objeto o artefacto utilizado para amenazar o dañar a la víctima.

Las "amenazas de muerte" son frases emitidas por el individuo indicando la voluntad o deseo de matar a la víctima (por ejemplo, "si intentas gritar socorro, te mato" o "siempre me he imaginado como sería matar a alguien"). Las frases menos explícitas (por ejemplo, "se te ha acabado el tiempo") se deben considerar amenazas de muerte si se acompañan de comportamientos que causan, o potencialmente causarían, daño físico grave a la víctima (por ejemplo, estrangulación, tortura).

"Mientras cometía" significa durante un acto de violencia sexual o previo al delito sexual.

A la hora de codificar este ítem los evaluadores deben tener en cuenta los auto-registros y los registros provenientes de fuentes colaterales fiables, además del registro delictivo formal del individuo.

16. Progresión en la frecuencia y/o gravedad de los delitos sexuales

Justificación

Algunas consideraciones anecdóticas sugieren que ciertas personas muestran un patrón claro de progresión en la comisión de actos de violencia sexual. Este factor se solapa conceptualmente con otros: la progresión en la frecuencia se puede ver reflejado en parte por una alta frecuencia de delitos sexuales recientes (ítem 12) y la progresión en la gravedad por el uso de violencia física, armas o amenazas de muerte en delitos recientes (ítem 14 y 15). Sin embargo, el aspecto diferencial de este factor es que capta la "trayectoria" a través del tiempo de la violencia cometida por el individuo (Greenland, 1985). No existe una evidencia clara de que este factor sea predictor de violencia sexual (Hanson y Brussière, 1996), quizás porque es raro o porque no se examina habitualmente. A través de nuestra experiencia, los profesionales lo consideran un factor importante y se discute en algunas revisiones clínicas (Ross y Loss, 1991).

Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de desviación sexual (posiblemente sadismo sexual), así como de actitudes que apoyan o consienten la violencia sexual. Posiblemente esté asociado con todas las facetas del riesgo, esto es, la naturaleza, probabilidad, frecuencia, gravedad e inminencia de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de progresión en frecuencia o gravedad de la violencia sexual en la historia del sujeto evaluado.
?	Evidencia posible/parcial de progresión en frecuencia o en gravedad de la violencia sexual en la historia del sujeto evaluado.
No	No hay evidencia de progresión en frecuencia o gravedad de la violencia sexual en la historia del sujeto evaluado.

Notas

La "historia de violencia sexual" incluye todo acto de violencia sexual cometido por el individuo.

La progresión en "frecuencia" significa que el agresor ha cometido recientemente más actos de violencia sexual que en el pasado más lejano, teniendo en cuenta el tiempo en que tenía riesgo de comportarse violentamente (p.ej., oportunidades de cometer este tipo de delitos).

La "progresión en la gravedad" significa que, en relación con actos anteriores, los actos de violencia sexual recientes cometidos por el individuo implican más contacto directo con las víctimas, daño físico grave a las víctimas, o uso de armas o amenazas de muerte creíbles.

A la hora de codificar este ítem los evaluadores deben tener en cuenta los auto-registros y los registros provenientes de fuentes colaterales fiables, además del registro delictivo formal del individuo. Las progresiones en frecuencia y gravedad se pueden identificar fácilmente mediante una cronología bien elaborada de la historia de violencia sexual del individuo.

17. Minimización extrema o negación de los delitos sexuales

Justificación

En la bibliografía clínica a menudo se sostiene que los agresores sexuales minimizan la gravedad de los actos de violencia cometidos previamente, reducen la responsabilidad personal de sus actos violentos, o incluso niegan totalmente estar involucrados en la violencia cometida anteriormente. No existe ninguna evidencia clara que apoye la capacidad de este factor de predecir la violencia sexual futura, aunque sí predice la criminalidad general de los agresores sexuales (Hanson y Brussière, 1996). Según las revisiones clínicas existentes éste es un factor importante a tener en cuenta a la hora de realizar valoraciones clínicas de riesgo (Greer, 1991; McGovern y Peters, 1988; Ross y Loss, 1991). Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de trastorno de personalidad o actitudes que apoyan o consienten la violencia sexual. Posiblemente esté relacionado con la probabilidad y frecuencia de la violencia sexual futura.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo manifiesta una minimización extrema o negación de los actos de violencia sexual cometidos en el pasado.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo manifiesta una minimización extrema o negación de los actos de violencia sexual cometidos en el pasado.
No	No hay evidencia de que el individuo manifieste una minimización extrema o negación de los actos de violencia sexual cometidos en el pasado.

Notas

La "minimización extrema o negación" significa que el individuo niega muchos o todos los actos de violencia sexual cometidos en el pasado; niega la responsabilidad personal de dichos actos, parcial o totalmente (por ejemplo, culpa a la víctima); o niega las consecuencias graves de dichos actos, parcial o totalmente (por ejemplo, dice que la víctima no sufrió lesiones físicas).

Los juicios emitidos de los evaluadores deben basarse en una comparación entre los auto-informes de la historia delictiva del individuo y la información recogida de otras fuentes, como por ejemplo, informes policiales, declaraciones de la víctima, registros de los hospitales y entrevistas con miembros de la familia.

18. Actitudes que apoyan o consenten los delitos sexuales

Justificación

Las personas que realizan comportamientos delictivos violentos respaldan actitudes (creencias y valores) socio-políticas, religiosas, (sub-) culturales y personales que apoyan o consenten su comportamiento (Andrews y Bonta, 1994). En la medida en que las creencias o actitudes se utilicen para minimizar o negar los delitos cometidos en el pasado, este factor se solapa conceptualmente con el anterior (ítem 17). No existe evidencia clara que apoye la capacidad de este factor de predecir la violencia sexual futura (Hanson y Brüssière, 1996), pero algunas revisiones clínicas lo consideran un factor importante a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo las valoraciones clínicas de riesgo (Greer, 1991; McGovern y Peters, 1988).

Este factor podría estar relacionado causalmente con la violencia sexual futura. De acuerdo a algunos modelos psico-sociológicos, ciertas actitudes pueden influenciar las decisiones tomadas por los individuos que consenten la violencia sexual, reduciendo la tendencia o gravedad percibidas de dañarse a sí mismo o a otros. De manera alternativa, las actitudes pueden ser un marcador de riesgo que reflejan la presencia de desviación sexual, trastorno de personalidad o minimización extrema o negación de los delitos sexuales cometidos en el pasado. Este factor probablemente está relacionado con la tendencia y frecuencia de la violencia sexual futura; las actitudes específicas pueden estar relacionadas con la naturaleza y gravedad de cualquier acto violento.

Codificación

SI	Evidencia de que el individuo sostiene actitudes que apoyan o consenten la violencia sexual.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo sostiene actitudes que apoyan o consenten la violencia sexual.
No	No hay evidencia de que el individuo sostiene actitudes que apoyan o consenten la violencia sexual.

Notas

Las "actitudes que apoyan o consenten la violencia sexual" incluyen creencias o valores socio-políticos, religiosos, culturales o sub-culturales y personales que promueven o justifican el sexo coercitivo, así como el sexo con menores, etc.

Las actitudes se pueden inferir a partir del comportamiento. Sin embargo, tales inferencias tienden a ser más precisas cuando están basadas en un patrón de comportamiento, más que en un acto concreto.

Ítems con referencia a planes para el futuro

La sección planes para el futuro consiste de dos ítems. Estos ítems se refieren tanto al funcionamiento actual como al funcionamiento futuro.

19. Carencia de planes de futuro realistas

Justificación

Las personas que fracasan en elaborar planes adecuados, seguros y realistas para conseguir el alta de una institución tienen un riesgo incrementado de criminalidad y violencia posterior a su puesta en libertad (Andrews y Bonta, 1994; Bartels, Drake, Wallach y Freeman, 1991; Estroff y Zimmer, 1994). Tales planes se deben adaptar a las necesidades del individuo e incluir objetivos tales como el lugar de residencia, empleo, las relaciones familiares y las relaciones con los profesionales penitenciarios y de atención sanitaria. Aunque este factor de riesgo ha recibido poca atención en las investigaciones publicadas, se suele incluir en algunas revisiones clínicas (Ross y Loss, 1991).

Este factor puede estar relacionado causalmente con la violencia sexual futura. La carencia de planes realistas puede llevar a la angustia psicológica, que a su vez puede llevar a incrementar pensamientos o impulsos sexuales desviados a corto plazo (Proulx et al., 1997). Por ello, una historia previa de pobre planificación podría estar relacionada con el aumento en la probabilidad y frecuencia de la violencia sexual futura, y problemas actuales referidos a las metas y los objetivos con la inminencia de la violencia.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo ha fracasado en establecer y mantener planes de futuro realistas.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo ha fracasado en establecer y mantener planes de futuro realistas.
No	No hay evidencia de que el individuo haya fracasado en establecer y mantener planes de futuro realistas.

Notas

Los "planes de futuro" son las intenciones del individuo acerca de su proyecto de adaptación en la comunidad. Esto incluye relaciones, empleo, lugar de residencia, cuidado sanitario y el cumplimiento con las condiciones de supervisión establecidas por la ley civil o penal. Los evaluadores deben considerar los planes actuales del individuo, así como los planes que él o ella haya realizado en el pasado.

El término "realista" se refiere a la tendencia del individuo a elaborar planes que sean explícitos, estables y razonables. Lo razonable debe ser evaluado a partir de su historia, estatus actual y la probabilidad de recibir apoyo de sus allegados y de los profesionales.

20. Actitud negativa hacia la intervención

Justificación

Las personas que rechazan apoyo penitenciario o sanitario o que carecen de motivación para hacer uso de este apoyo tienen un riesgo incrementado de criminalidad y violencia (Andrews y Bonta, 1994; ver también Webster et al., 1997). Acerca de los agresores sexuales, existe alguna evidencia de que, en caso de fracaso, el rechazo o el abandono del tratamiento predicen la violencia sexual futura (May, 1995; Hanson y Brusiére, 1996). Este factor de riesgo también se ha considerado en las revisiones clínicas (Greer, 1991; McGovern y Peters, 1988; Murphy et al., 1992; Ross y Loss, 1991).

Las actitudes negativas hacia la intervención pueden estar relacionadas de manera causal con la violencia sexual futura. Estas pueden llevar a un apoyo profesional inadecuado, que a su vez puede llevar a: (a) oportunidades reducidas de disminuir la desviación sexual del individuo; (b) oportunidades incrementadas de que el individuo experimente angustia psicológica; o (c) oportunidades incrementadas de que el individuo esté expuesto a factores desestabilizantes, tales como drogas ilícitas o fácil acceso a las víctimas, mientras reside en la comunidad. Este factor de riesgo puede estar relacionado con una probabilidad y frecuencia incrementadas de cometer actos de violencia sexual futura, y los problemas actuales acerca de las actitudes con la inminencia de la violencia.

Codificación

Si	Evidencia de que el individuo tiene una actitud negativa hacia la intervención.
?	Evidencia posible/parcial de que el individuo tiene una actitud negativa hacia la intervención.
No	No hay evidencia de que el individuo tenga una actitud negativa hacia la intervención.

Notas

La "actitud negativa hacia la intervención" incluye creencias y valores personales que promueven o excusan la falta de participación en el tratamiento, minimización o servicios de apoyo ofrecidos por los profesionales médicos, psiquiátricos, penitenciarios y trabajadores sociales. La falta de participación en los programas de tratamiento incluye rechazo en asistir, abandono prematuro y participación superficial en los programas. Los evaluadores deben considerar la actitud actual del individuo, así como la actitud que él o ella ha expresado en el pasado.

La actitud hacia la intervención puede ser inferida del comportamiento. Sin embargo, tales inferencias tenderán a ser más precisas cuando estén basadas en un patrón de comportamiento, más que en un comportamiento concreto.

Otras consideraciones

Justificación

Los autores han reservado un espacio para factores de riesgo raros/infrecuentes no incluidos en el SVR-20 como ítems separados, pero que son importantes. Estos pueden incluir, pero no sólo se limitan a, los siguientes:

Trastorno mental agudo que no reúne los criterios para un diagnóstico de trastorno mental grave (ítem 4). Un ejemplo es el Trastorno Adaptativo secundario a sucesos vitales estresantes.

Pérdida reciente de redes de apoyo social no atribuible a la ruptura conyugal (ítem 7) o a la pérdida de empleo (ítem 8). Un ejemplo de esto sería la pérdida de contacto con la familia y amigos debido al cambio de residencia o a un conflicto interpersonal.

Contacto frecuente con víctimas potenciales que no sea resultado de la carencia de planes realistas (ítem 19) o actitud pobre hacia la intervención (ítem 20). Un ejemplo de ello es empezar un nuevo empleo en el contexto de ofrecer servicios a personas vulnerables (por ejemplo, jóvenes, ancianos o discapacitados).

Codificación

SI	Presencia de un importante factor de riesgo específico del caso.
?	Presencia posible/parcial de un importante factor de riesgo específico del caso.
No	Ausencia de un importante factor de riesgo específico del caso.

Notas

"Importante" significa que el factor de riesgo se considera crucial para determinar la probabilidad de que el individuo cometa otro acto de violencia sexual, o para determinar la naturaleza, frecuencia, gravedad o inminencia de dichos actos.

"Específico del caso" significa que el factor de riesgo no cabe en la definición de los demás ítems del SVR-20.

Bibliografía

- Abel, G. G., Mittelman, M. S., & Becker, J. V. (1985). Sexual offenders: Results of assessment and recommendations for treatment. In M. H. Ben-Aron, S. J. Hucker, & C. D. Webster (Eds.), *Clinical criminology: The assessment and treatment of criminal behavior* (pp. 191-206). Toronto: M&M Graphics.
- Abel, G. G., & Rouleau, J. (1990). The nature and extent of sexual assault. In W. L. Marshall, D. R. Laws, & H. E. Barbaree (Eds.), *Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offender* (pp. 9-21). New York: Plenum.
- Abrams, S. (1991). The use of polygraphy with sex offenders. *Annals of Sex Research*, 4, 239-263.
- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.). Washington, DC: Author.
- Andrews, D. A., & Bonta, J. (1994). *The psychology of criminal conduct*. Cincinnati, OH: Anderson.
- Association for the Treatment of Sexual Abusers. (1993). *The ATSA Practitioner's Handbook*. Lake Oswego, OR: Author.
- Atkinson, R. L., Kropp, P. R., Laws, D. R., & Hart, S. D. (1995). *The Sex Offender Risk Assessment Guide*. Unpublished manuscript.
- Barbaree, H. E. (1991). Denial and minimization among sex offenders: Assessment and treatment outcome. *Forum on Corrections Research*, 3(4), 30-33.
- Bartels, S. J., Drake, R. E., Wallach, M. A., & Freeman, D. H. (1991). Characteristic hostility in schizophrenic outpatients. *Schizophrenia Bulletin*, 17, 163-171.
- Bélanger, N., & Earls, C. (1996). Sex offender recidivism prediction. *Forum on Corrections Research*, 8(2), 22-24.
- Bernstein, P. L. (1996). *Against the gods: The remarkable story of risk*. New York: Wiley.
- Boer, D. P., Wilson, R. J., Gauthier, C. M., & Hart, S. D. (1997). Assessing risk for sexual violence: Guidelines for clinical

SVR-20

Hoja de codificación

Evaluación de:	
Nombre: _____	Edad: _____

Especificar período de tiempo en que se evalúa el Cambio reciente: _____
--

Funcionamiento psicosocial

	Presencia (N, ?, S)	Cambio reciente (+, 0, -)
1. Desviación sexual	☐	☐
2. Víctima de abuso en la infancia	☐	☐
3. Psicopatía	☐	☐
4. Trastorno mental grave	☐	☐
5. Problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas	☐	☐
6. Ideación suicida / homicida	☐	☐
7. Problemas interpersonales	☐	☐
8. Problemas de empleo / laborales	☐	☐
9. Antecedentes de delitos violentos no sexuales	☐	☐
10. Antecedentes de delitos no violentos	☐	☐
11. Fracaso en las medidas de supervisión previas	☐	☐

Delitos sexuales

12. Frecuencia elevada de delitos sexuales	☐	☐
13. Tipología múltiple de delitos sexuales	☐	☐
14. Daño físico a la (s) víctima(s) de los delitos sexuales	☐	☐
15. Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexuales	☐	☐
16. Progresión en la frecuencia y gravedad de los delitos sexuales	☐	☐
17. Minimización extrema o negación de los delitos sexuales	☐	☐
18. Actitudes que apoyan o justifican los delitos sexuales	☐	☐

Planes de futuro

19. Carencia de planes realistas

20. Actitud negativa hacia la intervención

Otras consideraciones

- _____
- _____

Codificación resumen del riesgo

Bajo

Moderado

Alto

1. Riesgo de violencia sexual

Evaluación llevada a cabo por:

Nombre: _____

Título: _____

Firma: _____

Fecha: _____

La violencia sexual contra las mujeres y los menores, en sus diferentes formas, se ha ido delimitando como una de las áreas delictivas más complejas y dañinas en las sociedades modernas. Múltiples actuaciones, especialmente punitivas y de tratamiento, responden a esta realidad criminológica que parece resistente a los parámetros habituales de otro tipo de comportamientos violentos ya que la violencia sexual tiene unas tasas de reincidencia elevadas y una importante persistencia a lo largo de la vida de los agresores. En este contexto la predicción del riesgo de violencia sexual se presenta como una de las estrategias más eficaces en la reducción de la prevalencia de este tipo de delitos y por tanto en la victimización que provoca. Para esta tarea se ha diseñado el SVR-20 y que consiste en una guía para la valoración del riesgo de comportamientos de abuso y agresión sexuales sobre cualquier tipo de víctimas. Este SVR-20 es de uso sencillo para psicólogos y psiquiatras forenses, especialistas en el tratamiento de agresores sexuales, técnicos penitenciarios y en general para todos aquellos profesionales, incluyendo abogados y jueces, que trabajan directamente en la gestión de riesgos de la violencia sexual.

www.publicacions.ub.es



UNIVERSITAT DE BARCELONA

